U.F. 0122 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN DOMICILIO.

1. PSICOLOGÍA BÁSICA APLICADA A LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL DOMICILIARIA DE PERSONAS DEPENDIENTES.

1.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

1.1.1. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

El primer problema que se plantea a la hora de estudiar la población dependiente es identificar cuáles son esos actos corrientes de la vida diaria que deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar si una persona se encuentra o no en situación de dependencia, por necesitar una ayuda o asistencia importante para realizarlos.

Para ello, puede utilizarse un concepto utilizado desde hace tiempo por disciplinas como la rehabilitación o la geriatría, el de "actividades de la vida diaria" (normalmente denotadas con las siglas AVD).

Las actividades de la vida diaria (AVD) son aquellas actividades que una persona ha de realizar diariamente para poder vivir de forma autónoma, integrada en su entorno habitual y cumpliendo su rol social. Se puede decir que una persona dependiente es aquella que requiere ayuda para la ejecución de una o de varias de estas actividades de la vida diaria.

Es habitual diferenciar entre :
- las actividades básicas de la vida diaria (ABVD),
- actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) y
- actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD).

a) Actividades básicas de la vida diaria (ABVD)

Son las actividades imprescindibles para poder subsistir de forma independiente. Dotan al sujeto de una autonomía e independencia elementales. Son las referentes al autocuidado y la movilidad. Son las más básicas, por tanto, las últimas en alterarse. Su dependencia es incompatible con la vida a no ser que se proporcionen los cuidados adecuados.
Entre ellas se incluyen:

- Las actividades de autocuidado: bañarse, aseo e higiene personal (bucal y facial, afeitado y peinado), vestirse y desnudarse, poder ir solo al servicio, poder quedarse solo durante la noche, comer...)
- Las actividades de funcionamiento básico físico (desplazarse dentro del hogar)
- Las actividades de funcionamiento básico mental (reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar instrucciones y/o tareas sencillas).

b) Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)

Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de autonomía personal. Por lo tanto se alteran antes que las ABVD. Son las que permitan a la persona adaptarse a su entorno y mantener la independencia en la comunidad.

Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domésticas, tareas de administración del hogar y de la propiedad, como poder utilizar el teléfono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas de los pies, subir una serie de escalones, coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar lo que se necesita para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), tomar la medicación, cuidar de otras personas, poder pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Las tareas de este grupo se clasifican en:

- Tareas de atención doméstica: se refieren al cuidado y mantenimiento del hogar.
- Tareas de atención personal: son las que se realizan directamente con el usuario (ayudarle a comer, ayudar en su aseo...).

c) Actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD)

Son conductas elaboradas de control del medio físico y del entorno social, que permiten al individuo desarrollar un rol social, mantener una buena salud mental y disfrutar de una excelente calidad de vida.

Son conductas elaboradas, muy complejas y diversas, ya que dependen del estilo de vida individual, de sus gustos, del nivel social alcanzado... Engloban:

- Actividades físicas:
  - ejercicio físico intenso: conocer reglas de deportes individuales que practica, practicar deportes individuales,

y que pueden implicar un riesgo de accidentes (alto o bajo) como caza, natación, tenis...
- trabajo físico intenso: lavar el coche y limpiarlo por dentro, actividades de jardinería, bricolaje...

- Actividades sociales: programar viajes, preparar la maleta, ir al cine, debatir noticias, ir a bailar, relacionarse con los demás, felicitar cumpleaños, participar en el cuidado de otras personas...

- Actividades mixtas: practicar y/o conocer las reglas de deportes en grupo , con riesgo alto o bajo de accidentes como el fútbol, tiro al plato, conocer los útiles de trabajo, conocer el desarrollo de su trabajo...

Estas tareas deberemos realizarlas junto con la persona siempre que sea posible, además de hacerlas adaptándonos a sus características y manera de hacerlas. Es imprescindible personalizar cada actividad al usuario, realizar un análisis individualizado desde la perspectiva integral del modelo biopsicosocial. Cuidamos al usuario en su domicilio, un espacio íntimo y personal, en el que él se siente seguro y por tanto puede desarrollar su personalidad con total libertad. Por ello debemos conocer las características generales de estas personas a las que vamos a atender.

Es por ello que vamos a estudiar los procesos de envejecimiento, los cambios que se producen, el entorno socioafectivo, la sexualidad y las repercusiones en las necesidades de estas personas.

1.1.2. CICLO VITAL

A lo largo de su vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte, el ser humano va sufriendo una serie de cambios y pasando por una serie de etapas que conocemos como ciclo vital: infancia, adolescencia, juventud, madurez y senectud. El paso entre estas etapas y la duración en cada una de ellas será diferente para cada persona.

Según la Organización Mundial de la Salud, la **capacidad funcional** de cada persona (resistencia, capacidad cardiovascular,...) está ligada al momento del ciclo vital en que se encuentra. Se desarrolla desde la niñez hasta alcanzar su cota máxima en la edad adulta. A partir de este momento se inicia un descenso, distinto para cada persona, en función de distintos **factores**, como:

- Fisiológicos: Tienen que ver con la dotación genética, las características físicas, la maduración del sistema nervioso, etc.
- Psicológicos: Afectividad, estabilidad emocional, sociabilidad...

- Medioambientales: Entorno sociocultural, alimentación y hábitos nutricionales, adicciones, estimulación, acceso a la educación, entorno económico, condiciones higiénico-sanitarias, trabajo que se realiza...

1.1.3. CONDUCTA

Entendemos por conducta cualquier comportamiento que realice el ser humano. Se refiere y está influenciado por el pensamiento, los movimientos físicos, las respuestas emocionales, etc. Así mismo, está condicionado por factores biológicos (genéticos e innatos, desde el nacimiento) y factores ambientales (conductas aprendidas en la familia, en la escuela...). No toda la conducta humana es aprendida. Nacemos ya con unos patrones conductuales innatos. Pero las diferencias individuales se deben también a las motivaciones de cada uno, fines que se persiguen, el momento concreto en que una conducta se produce...

Teniendo en cuenta que la conducta se produce como parte de la relación social, cabe distinguir tres **tipos de comportamiento**:

- Pasivo:
  - Las necesidades de los demás se anteponen a las propias
  - No se defienden los derechos propios
  - Actitud sumisa
- Agresivo
  - Se anteponen las necesidades propias a las de los otros.
  - No se tienen en cuenta los derechos de otras personas.
  - Prevalecen los deseos personales.
  - Actitud violenta (física y verbal).
- Asertivo
  - Se defienden los derechos propios a la vez que los de los demás.
  - Actitud conciliadora.

1.1.4. PROCESOS COGNITIVOS

Los **procesos cognitivos** son las funciones mentales superiores (procesos psíquicos) que tienen lugar en el cerebro, como por ejemplo la atención, la memoria, la percepción,... Determinan el procesamiento de la información, la adquisición de conocimientos, la planificación, etc. Como intervienen directamente en la realización de las AVD, vamos a ver algunos de ellos.

1.1.4.1. PENSAMIENTO

Pensamos cuando usamos ideas o conceptos mentales en lugar de objetos. El pensamiento relaciona conceptos, los organiza en categorías y sistemas más amplios.

Evoluciona desde el nacimiento hasta la edad adulta, pasando por distintas etapas de maduración: *pensamiento mágico o primitivo* al comienzo (las personas se rigen por similitudes por no poder aún abstraer ideas o conceptos; posteriormente *pensamiento concreto* (se utilizan y relacionan solamente elementos presentes (sólo existe lo que se percibe) y por último la etapa del *pensamiento abstracto*, que ya puede trabajar con ideas o conceptos (no se refieren a ningún objeto real presente en el exterior, como por ejemplo la bondad, el perdón, la amistad,...).

1.1.4.2. ATENCIÓN

La atención es el proceso cognitivo que selecciona los estímulos para poder procesar la información. Varía en función de la situación y de las actividades que realiza la persona. Se ve afectada tanto por los estímulos (color, forma, tamaño, movimientos que presentan) y por condicionamientos de la persona (cansancio, interés ante determinados estímulos: por ejemplo, si estamos en silla de ruedas parece que vemos más gente en silla como nosotros que nunca...

1.1.4.3. LENGUAJE

Es el sistema organizado de símbolos que permite la comunicación de pensamientos o conceptos, así como favorece su formación y enriquecimiento. Puede ser oral o escrito.

1.1.4.4. MEMORIA

Es el proceso por el cual se registra, retiene y recupera la información. Es un proceso que permite a la persona hacer uso del repertorio de conocimientos y experiencias acumuladas a lo largo de su experiencia.

Existen muchos **tipos de memoria**: explícita, implícita, semántica, episódica, ... Nos vamos a ocupar de estos tres tipos de memoria:

- Memoria sensorial (MS): se puede considerar parte de la percepción. Su duración es muy corta. Por ejemplo: el olor de un perfume.
- Memoria a corto plazo (MCP): De duración corta. Y capacidad limitada. Su información o se pierde o se procesa y pasa a un almacén más estable. Es la memoria que utilizamos por ejemplo cuando nos dicen un número de teléfono para recuperarlo justo en ese momento y poderlo marcar. Se llama también memoria de trabajo.
- Memoria a largo plazo (MLP): También llamada memoria remota. Su capacidad es casi ilimitada, la información aquí guardada

permanece largo tiempo. Se pueden distinguir 2 tipos de MLP importantes:

-M. Declarativa : recordar palabras, imágenes, sucesos..
-M Procedimental: recordar acciones (andar en bicicleta, pelar patatas, afeitarse..)

1.1.4.5. MOTIVACIÓN

La motivación es la fuerza interna que impulsa la conducta humana en busca de satisfacción, nos conduce a realizar una conducta u otra.

La conducta se origina por un motivo y se dirige a una meta, un objetivo. Cada motivo puede tener diferente origen, intensidad y finalidad. **Los motivos podemos clasificarlos en:**

- Primarios: Están relacionados con las necesidades corporales o de adaptación al ambiente (sed, hambre, sueño, temperatura corporal, sexo, evitar el dolor, explorar, manipular objetos...)
- Secundarios: Están relacionados con el logro, la filiación y el poder. Son aprendidos y dependen del contexto cultural de la persona.

En la Teoría de la Personalidad de **Maslow**, se estudian y ordenan las necesidades humanas, que son la base del comportamiento. Se ordenan en una **pirámide,** de 5 niveles: cada uno corresponde a un nivel de motivación. Abajo están situadas las necesidades más básicas, de tal forma que mientras no estén satisfechas, no se buscará satisfacer las del nivel superior. El orden en el que quedarían las necesidades dentro de la pirámide, comenzando por la base, es el siguiente:

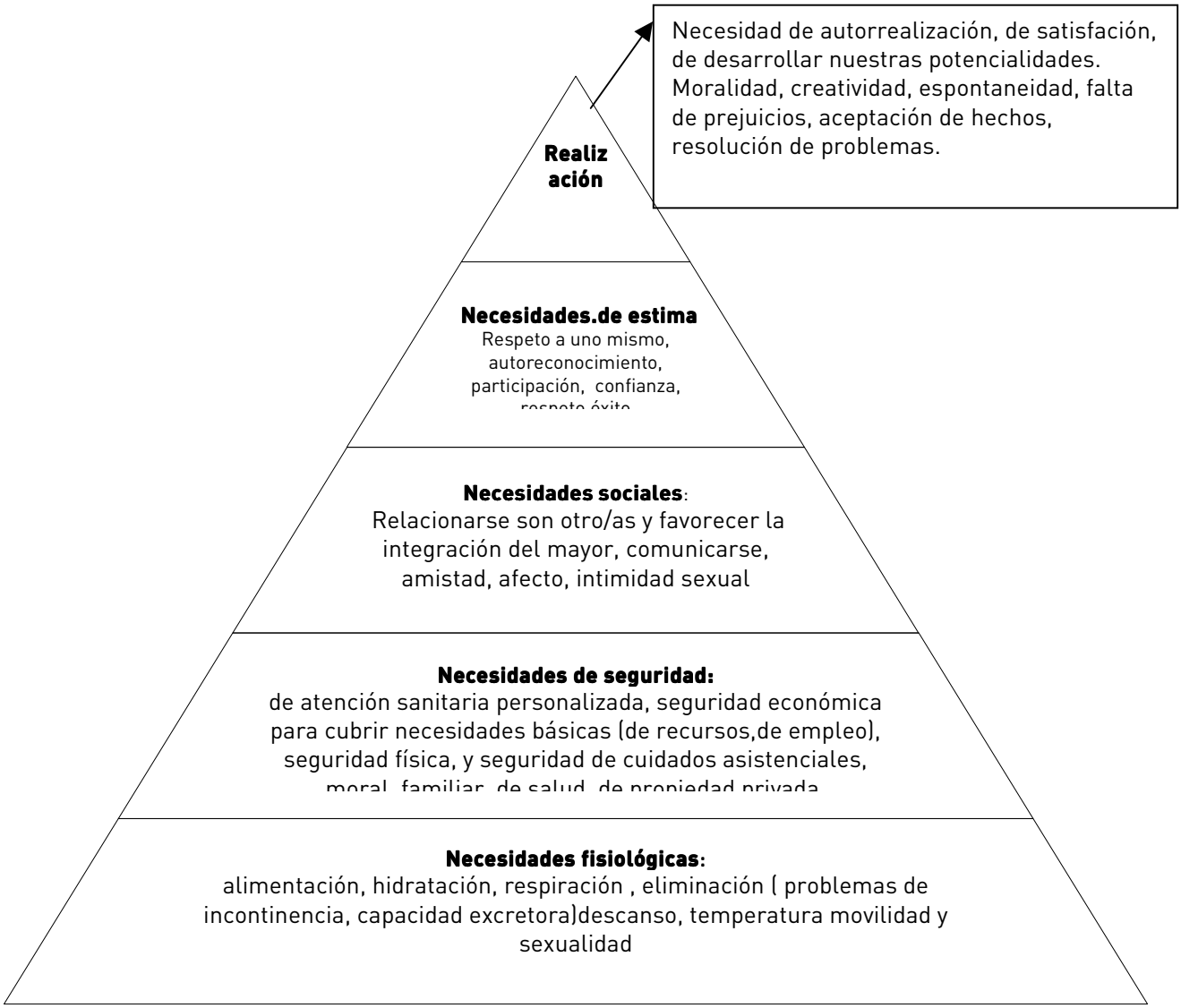
- Necesidades fisiológicas: son las más importantes: alimentarse, beber, respirar, dormir... Sólo cuando el individuo tiene satisfechas estas necesidades aparece la posibilidad de cubrir las necesidades de niveles superiores.

- Necesidades de seguridad: Protección frente a amenazas de orden físico, económico y psicosocial.

- Necesidades sociales: necesidades de afecto y pertenencia a determinados grupos, donde los lazos afectivos son intensos: amistad, amor, vinculación a grupos sociales identificadores...La no satisfacción de las necesidades de este grupo origina numerosos desajustes psicológicos e incluso psicopatologías.

- Necesidades de estima: necesidades de prestigio y poder, de reconocimiento y estima por parte de otros, de reputación.

- Autorrealización: necesidad de realizar las propias potencialidades.



Si atendemos al origen del impulso o motivación, del motivo para realizar una acción, la motivación puede ser :

- intrínseca: surge del interior de la persona, del placer por realizarla, ej. Las aficiones)
- extrínseca: si realizamos una actividad por un motivo externo, por ej. para obtener un premio o evitar un castigo.

1.1.4.6. EMOCIÓN

Las emociones son estados de ánimo que surgen al dar significado a determinados estímulos internos (cambios fisiológicos –corporales- y ciertos pensamientos) y otros externos. Son un componente fundamental de la esencia

humana, que estructuran la personalidad y motivan el comportamiento, impulsan a actuar. La emoción está muy relacionada con la motivación.

Aparece como respuesta a algo, se inicia con un agente externo (situación) o interno (recuerdo), luego aparecen en el organismo efectos fisiológicos, conductuales, expresivos y sociales.

Podemos **clasificar las emociones** en:

- Básicas: Están presentes desde el nacimiento y aparecen de la misma manera en todas las culturas. Algunas son positivas, como la alegría, que nos provoca felicidad y bienestar. Otras son negativas como el miedo, que hace que nos protejamos, el asco (rechazo), la ira (destrucción) y la tristeza. La sorpresa es una emoción neutra.
- No básicas: no son universales sino que dependen del entorno, de la cultura en la que se viva. Por ejemplo, la vergüenza es una emoción que se va desarrollando en la persona siguiendo los valores culturales de la sociedad en la que vive.

Si las emociones se presentan de forma adecuada nos ayudan a adaptarnos al entorno (regulando nuestro pensamiento, evitando situaciones de descontrol...). El control de las emociones está muy relacionado con la inteligencia emocional (habilidad para percibir las emociones propias y de los demás, comprenderlas y regularlas de manera adecuada).

Cuando las emociones no cumplen su función adaptativa, aparecen las **alteraciones emocionales**; las que más observamos entre las personas con dependencia son:

- la ansiedad: Aparece como una reacción de alerta y activación ante situaciones interpretadas como amenazantes. Se da una sensación de inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva, tensión física. El trastorno de ansiedad se produce cuando este estado emocional perdura en el tiempo. Produce mal funcionamiento psicosocial y físico.
- la depresión: Es la expresión de tristeza continuada, abatimiento permanente, pérdida de interés por realizar actividades, dejadez, desarreglo personal. Disminuye la capacidad de concentración, pueden aparecer problemas de sueño y de memoria. Aumenta la sensación de fatiga.

Es importante detectar a tiempo estas alteraciones e intervenir, ya que pueden influir en la capacidad funcional de la persona y como consecuencia, aumentar su dependencia.

1.2. EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD Y CONVALECENCIA

El envejecimiento es una más de las etapas del ciclo vital, junto a la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Y, en esta etapa, al igual que en las anteriores se producen una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales.

El hecho fundamental del proceso de envejecimiento, es la pérdida progresiva de la capacidad de adaptación de la persona a circunstancias anómalas, internas o externas. Esto supone que en las condiciones habituales, la persona mayor, con sus características propias podrá tener un buen nivel de adaptación al medio que le rodea, pero será muy sensible a circunstancias (enfermedad, estrés de diverso tipo ...) que le exijan un sobreesfuerzo. En esta etapa las facultades empiezan a descender de forma variable en cada persona.

El envejecimiento es un proceso dinámico que afecta de manera continua e irreversible a todos los seres vivos. Es un proceso natural, gradual, con cambios y transformaciones que se producen a nivel biológico, psicológico y social. Envejecer no es sinónimo de enfermar, aunque el riesgo de padecer enfermedades se incremente con la edad.

Se trata además de un fenómeno universal (afecta a todos por el mero hecho del paso del tiempo), irreversible (no puede detenerse ni revertirse), con gran variedad interindividual (no todos envejecemos del mismo modo y al mismo ritmo) e intraindividual (los diferentes sistemas del cuerpo de una persona también envejecen a un ritmo distinto).

Debemos diferenciar entre varios **tipos de envejecimiento**:

- el envejecimiento fisiológico, el que se produce por el paso del tiempo y el efecto que tiene en la persona. No puede detenerse.
- el envejecimiento patológico, en el que intervienen enfermedades o situaciones que aceleran el proceso normal de envejecimiento.

Conviene también señalar las **diferencias entre algunos conceptos**, como:

- Edad cronológica: edad del individuo, tiempo real transcurrido desde su nacimiento.
- Edad psicológica: hace referencia a las características psicológicas y emocionales en función de la edad.
- Edad funcional: Se trata de la capacidad para desarrollar una vida independiente, conservar unos niveles razonables de capacidad física y psicológica que permitan a la persona mantener los roles personales y continuar integrado en la sociedad. Es esta edad la que puede definir la calidad de vida satisfactoria y el envejecimiento exitoso.

1.2.1. CAMBIOS BIOPSICOSOCIALES QUE SE PRODUCEN EN LA VEJEZ

El envejecimiento es un proceso en el que se producen transformaciones biológicas, corporales, psicológicas y sociales.

1.2.1.1. CAMBIOS BIOLÓGICOS

Son modificaciones que afectan a las estructura y funciones del organismo

- Las células pierden capacidad de regeneración
- La piel se afina y se arruga
- El sistema musculoesquelético pierden masa y como consecuencia fuerza física, los huesos se vuelven frágiles.
- El sistema cardiorespiratorio: el corazón disminuye de tamaño y las venas y arterias pierden elasticidad y se endurecen
- Respecto al sistema digestivo: pérdida de piezas dentales (problemas de masticación), disminución de la saliva (boca seca)
- Sistema genitourinario: pérdida del tono de la vejiga (pérdidas de orina), disminuye el volumen de los riñones, agrandamiento de la próstata en los hombres, menopausia en las mujeres.
- Sistema inmunitario disminuido, por lo tanto más riesgo de infecciones.
- Sistema nervioso . disminución de las neuronas, las cuales pierden su capacidad de regeneración
- Disminuye la agudeza visual
- Pérdida auditiva
- Disminución de las papilas gustativas.

1.2.1.2. CAMBIOS PSICOLÓGICOS Y EMOCIONALES

- Se altera la memoria reciente o MCP ,esencial para el aprendizaje y la adaptación a nuevas situaciones . Sin embargo, la memoria a largo

plazo (MLP) o memoria remota, se mantiene sin grandes variaciones.

- Disminuye la capacidad de atención y concentración, relacionada por la falta de interés por las cosas que le rodean.
- Pérdida de la capacidad de resolver problemas novedosos
- Aumenta la dificultas para aprender nuevos conocimientos. La velocidad de aprendizaje es menor. El aprendizaje es posible si se da en entornos conocidos y materiales significativos. Deberemos proponer aprendizajes prácticos, puesto que aquellos que requieran rapidez, y pensamiento abstracto resultan más complicados para las personas de edad avanzada.
- La percepción también está alterada tanto para recibir información (a través de vista, oído, gusto y olfato) como para procesarla.
- La creatividad se mantiene sin variaciones
- En cuanto al funcionamiento intelectual parece que es más lento
- La personalidad, en general no se observan cambios importantes, aunque si podemos observar una acentuación de los rasgos del carácter y una reducción de la capacidad para adaptarse a las situaciones nuevas desconocidas, por lo que tienden a buscar entornos estables y cercanos que transmitan sensación de seguridad.

1.2.1.3. CAMBIOS SOCIALES

- Durante el proceso de envejecimiento, la persona cambia de roles (funciones) sus hábitos de vida, lo cual afecta a la forma de relacionarse. Pasa de ser capaz de trabajar (rol laboral) a la jubilación, disminuyendo sus ingresos económicos y su papel en la comunidad.

1.2.2. INCIDENCIAS EN LA CALIDAD DE VIDA

(Como Unidad Formativa 119, punto 1.1.4.)

1.2.3. LA ENFERMEDAD EN EL MAYOR

(Como Unidad Formativa 119, punto 1.1.5.)

1.2.4. EVOLUCIÓN DEL ENTORNO SOCIOAFECTIVO Y DE LA SEXUALIDAD DE LA PERSONA MAYOR

(Como Unidad Formativa 119, punto 1.1.6.)

1.2.5. NECESIDADES ESPECIALES DE ATENCIÓN Y APOYO INTEGRAL

Como ya estamos viendo el proceso de envejecimiento se desarrolla de forma diferente en cada persona, pero no es sinónimo de enfermedad ni causa dependencia por sí solo. Eso sí a lo largo de los años se dan cambios bio-psico-sociales y por lo tanto las necesidades también cambian en función de las capacidades y los déficits que presente cada persona.

De forma general**, durante el proceso de envejecimiento surgen una serie de necesidades especiales** (siguiendo la clasificación de las necesidades de Maslow):

- Necesidades fisiológicas: deberemos atender a la alimentación, hidratación, respiración , eliminación, descanso, mantenimiento de la temperatura, movilidad y sexualidad.

- Necesidades de seguridad: atención sanitaria, seguridad económica (tener asegurados unos ingresos que garanticen la cobertura de las necesidades básicas), seguridad física (las personas con demencia pueden desorientarse y perderse) y necesidad de cuidados asistenciales (cuidado personal, administración de medicamentos).

- Necesidades sociales: mantener lazos familiares, con amigos, pertenecer a un grupo social.

- Necesidades de estima: respeto y confianza en uno mismo, respeto de los demás.

- Autorrealización: tomar decisiones según sus valores y creencias.

La atención que se dispensa a las personas dependientes debe ser integral, en función de sus necesidades, comprendiendo un conjunto de actividades, servicios y prestaciones que contribuyan a la satisfacción de sus necesidades y

demandas biopsicosociales. En líneas generales, **los objetivos que se plantean son:**

- Mantener a la persona dependiente en el domicilio y en su entorno habitual el mayor tiempo posible.
- Favorecer su participación social, el ocio y el tiempo libre.
- Desarrollar alternativas de convivencia para quienes no puedan permanecer en el domicilio.
- Desarrollar programas de cooperación social.

El grado y nivel de dependencia que presente la persona determinarán las necesidades de apoyo que deba recibir. Por lo que se hace necesaria una valoración que recoja qué aspectos de la persona se encuentran afectados o limitados y si estas alteraciones corresponden a nivel físico, cognitivo o sensorial. Debe recoger también información sobre el entorno de la persona. A esta valoración se le denomina **Valoración Geriátrica Global** (incluye valoración médica, funcional, mental y social). A partir de ella se elabora un plan de atención individualizado **(PAI)**. El mejor apoyo no es atender a todo en todos los momentos. En definitiva, la mejor ayuda y la más adecuada es aquella que se dispensa cuando la persona realmente lo necesita.

1.2.6. CALIDAD DE VIDA, APOYO Y AUTODETERMINACIÓN EN LA PERSONA MAYOR

La calidad de vida de las personas mayores puede entenderse en torno a tres factores:

- El nivel de dependencia que presentan y en consecuencia, el grado de ayuda que precisan para la realización de las actividades de la vida diaria.
- Las expectativas que presentan en relación con la ayuda que desean recibir y la que reciben (servicios de proximidad, adaptación de la vivienda y ayudas técnicas).
- Los propios apoyos y atención que reciben de sus cuidadores informales (familia y amigos).

Los avances de la medicina, la mejora de la situación social, cultural y económica ha proporcionado una mayor esperanza de vida, nuestros mayores disfrutan de un bienestar y reivindican el ejercicio de su autonomía y autodeterminación, lo cual no significa que desatendamos sus necesidades. El apoyo que la persona precisa es aquél que refuerce sus habilidades, capacidades y creencias que le permitan mantener una conducta autónoma. Se puede necesitar, pedir y recibir apoyo sin perder autonomía.

Por tanto, el **apoyo en la autodeterminación de las personas dependientes** debe contemplar los siguientes puntos a los que el cuidador domiciliario debe atender:

- Facilitar las iniciativas de la persona, así como impulsar su participación en todas aquellas actividades relevantes en su vida.
- Conocer las preferencias e intereses de la persona dependiente, diferenciando entre lo que quiere y realmente necesita.
- Promover que las elecciones realizadas estén basadas en dichas preferencias, intereses, necesidades, etc.
- Ayudar a la promoción del establecimiento de metas personales.
- Fomentarla independencia dentro de un marco de interdependencia
- Favorecer y ayudar a la persona a autorregular su comportamiento y su interacción con los demás.
- Favorecer y facilitar que la persona dependiente se encuentre segura de sí misma, confiada, que valore sus logros, etc.

Por otra parte, el trato hacia las personas mayores debe tener en cuenta algunas **cuestiones éticas** que afectan a su autodeterminación y calidad de vida:

- La marginación de los mayores por cuestión de edad. Los mayores son considerados como una carga y no se les reconoce valores tradicionalmente considerados (la experiencia vital). Por ejemplo, a veces se les niega el acceso a determinados tratamientos sanitarios por considerarse un despilfarro de los recursos.
- Ejercicio de la autonomía personal sobre razones clínicas (por ejemplo , tratamientos a seguir). Salvo casos graves de dependencia, la persona mayor será la que decida sobre los aspectos sanitarios que le competen.
- Los maltratos a mayores, en los últimos años hay una mayor conciencia social del problema y de la necesidad de erradicarlo.
- Derecho sobre la propia vida. Existe una tendencia a infantilizar a los mayores y adoptar actitudes de sobreprotección que se hacen más evidentes cuando la persona necesita ayuda para las AVD. Tenemos que tener en cuenta que discapacidad física no implica discapacidad mental, y por lo tanto el entorno del mayor deberá respetar y asumir su voluntad. Esto resulta muy importante en la

planificación de los cuidados terminales: la manera de ser atendido y cómo desea dejar las cosas para cuando haya fallecido.

Es decir, una atención a las personas mayores debe considerar su dignidad como personas con autodeterminación, garantizándoles la mejor calidad de vida por derecho (no por caridad) en un ambiente de seguridad y respeto.

1.2.7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES, CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES EN ENFERMEDAD Y CONVALECENCIA

(Como Unidad Formativa 119, punto 1.2.)

2. RELACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES. HABILIDADES SOCIALES FUNDAMENTALES

Las relaciones sociales son el conjunto de interacciones que mantiene un individuo con otras personas o grupos de personas, los lazos que se establecen en esas interacciones y el tipo de interacciones dependiendo del ambiente en el que tienen lugar.
Desempeñan un papel esencial en el desarrollo integral de la persona. Si estas relaciones son satisfactorias, suponen una fuente importante de refuerzos sociales que facilitan la integración y la adaptación a la sociedad. Por el contrario, la carencia de determinadas habilidades sociales puede provocar rechazo, aislamiento, y en consecuencia limitaciones a la calidad de vida.

Algunas personas dependientes, debido a la situación que viven, tienden a tener un carácter cerrado, poco social (en parte debido a la negación, frustración o miedo) con las personas que les rodean y sobre todo con las personas que les ayudan y apoyan. Pueden aislarse en su propio domicilio, lo que afecta tanto a la frecuencia de sus relaciones interpersonales, como a la manera y habilidades para relacionarse con los demás. El profesional deberá observar estas dificultades y desarrollar estrategias para evitar la pérdida de relaciones sociales del usuario y favorecer la creación de nuevos lazos.

Los **grupos** con los que la persona puede tener relación y por lo **tanto forman parte de su red social** son los siguientes:

- Familia
- Amigos: personas con las que mantiene vínculos afectivos y de confianza.
- Compañeros de trabajo o estudios: personas con las que comparte un tiempo y espacio para realizar un actividad productiva o de adquisición de conocimientos.
- Compañeros de ocio: personas con las que comparte una afición (actividades como pintar, tertulias, visitas, senderismo, excursiones...)
- Otros: personas que nos prestan unos servicios determinados (médico, técnico de apoyo en domicilio, podólogo, tendero...).

Según el colectivo en el que se lleven a cabo las **relaciones sociales**, éstas pueden tener diferentes características:

- Relaciones sociales de las personas mayores:
  - Estarán determinadas por el estilo de vida de cada usuario, por el entorno socioafectivo mantenido en su juventud y adultez, por su estado de salud, por las condiciones socio-culturales.
  - Sienten preferencia por las relaciones primarias (familiares y amigos);
  - Menor motivación para mantener relaciones nuevas.
  - Necesidad de afrontamiento de pérdidas de seres queridos (pareja, amigos...) o cambio de roles (jubilación ..)
  -
- Relaciones sociales de las personas con discapacidad:
  - Inseguridad (sobretodo en las discapacidades adquiridas), lo que muchas veces lleva al aislamiento.
  - Carencias de habilidades sociales por actitudes de sobreprotección del entorno, dificultades para captar o transmitir información (deficiencias sensoriales e intelectuales), escasez de interacciones.
  - En ocasiones utilizan la discapacidad para manipular la interacción con los otros intentando dar pena, compasión, culpa...

- Relaciones sociales de las personas convalecientes o con enfermedad:
  - Disminución de las redes sociales.
  - Escasa motivación para establecer nuevas relaciones.
  - Interés centrado en ellas mismas.
  - Tendencia al aislamiento.
  - Sentimientos de ansiedad, tristeza, irritabilidad...

2.1.1. HABILIDADES SOCIALES FUNDAMENTALES

Las Habilidades sociales son aquellos comportamientos que nos permiten actuar con eficacia en las relaciones con otras personas (interpersonales).

Son comportamientos aprendidos, por lo que pueden entrenarse y modificarse. Puede que haya personas a las que les cueste menos relacionarse, y otras más tímidas que les cueste más, pero todo/as podemos aprender a relacionarnos. A continuación se indican unos mecanismos para trabajar las habilidades sociales (hhss):

Mecanismos básicos de aprendizaje de las Habilidades Sociales (HHSS)

- Refuerzo positivo: Los comportamientos que son recompensados tienen una alta probabilidad de repetirse.. Por ejemplo si una usuaria saluda con una sonrisa, es probable que el resto de los compañeros le sonrían; al contrario si se ignora su comportamiento, no volverá a repetirlo.

- Observación: El aprendizaje se produce a partir de observar a otras personas. Así si un residente saluda de forma cordial y las respuestas de sus compañeros son positivas, el observador tenderá a imitar esa conducta.

- Retroalimentación: Es la forma en que la otra persona nos informa de su reacción ante nuestra conducta. Por ejemplo, un usuario se dirige a la auxiliar "Tráeme un poco de pan", la respuesta será negativa, porque no se ha dirigido de forma cortés y la respuesta podría ser " me gustaría que me pidieras las cosas por favor".

- Creencias y expectativas: Se refiere a las esperanzas que tiene la persona sobre la posibilidad de tener éxito en una situación determinada.

Factores que componen las habilidades sociales

a) Factores Fisiológicos: Son las reacciones físicas que se producen cuando nos relacionamos con otras personas, por ejemplo: sudoración, ritmo cardíaco, temblor de voz....

b) Factores Conductuales: Son todos aquellos relacionados con el proceso de la comunicación. Podemos distinguir entre **Verbales** y **No verbales.**

- **Verbales**: son todos los elementos del lenguaje, lo utilizamos para expresar ideas, actitudes y sentimientos. Las palabras cambian en función del contexto en el que las utilicemos, por ello un dominio del lenguaje, favorecerá las relaciones sociales.
- **No verbales**: Son todas aquellas formas de comunicar sin tener en cuenta la palabra, incluye gestos, miradas, posturas corporales, distancia interpersonal. La comunicación no verbal actúa:
  - Apoyando la comunicación verbal, es decir, completando lo que decimos, comunicando opiniones y actitudes a través de miradas, expresiones faciales, posturas.
  - Sustituyendo al lenguaje, con un gesto somos capaces de transmitir una idea, por ejemplo asentir o negar con la cabeza, saludar alzando la mano.

La sonrisa, junto con la mirada, es un elemento fundamental en la comunicación, no verbal, facilita el inicio y final de las interacciones y suavizan los mensajes negativos.
Casi todas las interacciones sociales están reguladas por la mirada, con ella podemos expresar enfado, tristeza, desinterés, vergüenza, atracción, así como regular el turno de la conversación.

c) Factores Cognitivos: La forma como percibamos nuestro entorno, las ideas que nos hagamos sobre él, las interpretaciones que hagamos, las experiencias y conocimientos, influirán en las relaciones con las otras personas (entorno familiar privado, formal...). De igual forma también condicionarán las relaciones nuestros valores personales, nuestra forma de resolver situaciones conflictivas, nuestro autocontrol, nuestras preferencias y experiencias anteriores.

2.2. DIFICULTADES DE RELACIÓN SOCIAL. SITUACIONES CONFLICTIVAS

2.2.1. DIFICULTADES QUE AFECTAN A LAS HABILIDADES SOCIALES DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES

En general, existen posibles limitaciones en el repertorio de habilidades sociales de las personas con dependencia, como las que se mencionan a continuación:

- Falta de oportunidades sociales.
- Sentimientos de incompetencia social, ansiedad ante situaciones sociales, impulsividad, expectativas de fracaso, etc.
- Contextos sociales poco favorecedores, negativos para la persona dependiente, donde se manifiestan conductas de rechazo, minusvalía, recriminación sistemática de sus dificultades, etc.
- Falta de habilidad para iniciar o mantener conversaciones con otras personas.
- Falta de interés por mantener contacto con los otros.
- Falta de habilidad para expresar opiniones de forma adecuada.
- Dificultad para hacer peticiones.
- Falta de habilidad para recibir y realizar cumplidos.
- Dificultad para aceptar críticas.
- Dificultad para percibir y discriminar estímulos relevantes del entorno.
- Dificultad para generar alternativas de respuesta y valorarlas en función de sus posibles consecuencias.
- Dificultad para tomar decisiones y planificar el curso de la acción ante una situación social.
- Dificultad para evaluar la propia conducta y su adecuación a las exigencias del contexto.
- Dificultad para aprender de los errores y adecuar una futura acción.

2.2.2. SITUACIONES CONFLICTIVAS

Las dificultades de relación social pueden generar situaciones conflictivas tanto entre la persona con dependencia y las personas que conviven con ella, como entre el usuario y el técnico de apoyo a domicilio.

Los conflictos son situaciones de cambio que suelen considerarse como negativas por su carácter de confrontación inicial, y que sin embargo posibilitan la resolución del problema existente y un mejor ajuste personal entre las personas implicadas en el mismo, a través de una gestión adecuada del conflicto.

El periodo de adaptación al servicio de atención a la dependencia y al técnico es un momento delicado y pueden surgir situaciones conflictivas con facilidad. **Las causas más frecuentes de aparición de las situaciones conflictivas** son las siguientes:

- Sentimientos negativos del usuario ante su situación de dependencia, suelen aparecer comportamientos de irritabilidad por parte del usuario, al ver que su dependencia va en aumento y

necesita más ayuda de la que él quisiera para realizar las AVD. Desconfianza (objetos personales que se cambian de lugar, invasión de su espacio..), vergüenza (ante el aseo o la evacuación), tristeza.

- Visión equívoca de la situación de dependencia , a veces surge el conflicto porque al técnico se le han asignado unas tareas y el usuario prefiere que realice otras. Es importante que el técnico sea amable, pero se mantenga firme y transmita la necesidad de realizar las tareas asignadas.

- Habituación, otra situación que suele provocar conflicto es la sustitución de los técnicos domiciliarios (por vacaciones, bajas por enfermedad...), la relación que se establece con los usuarios suele ser muy estrecha y admitir a otra persona diferente en el propio domicilio no resulta fácil. Es importante presentar al compañero que le va a sustituir, explicarle cuáles son las tareas que realiza, e intentar que el usuario no perciba el cambio de una forma brusca.

- Cambios de la rutina diaria, actividades que se salen de la rutina diaria (celebraciones familiares, visitas...), suelen ser fuente de ansiedad, y en consecuencia generadoras de conflictos.

Es necesario conocer las situaciones conflictivas que puedan surgir con el fin de atenuar los factores que los desencadenan. Esto contribuirá al bienestar y la seguridad de los usuarios.

2.3. TÉCNICAS PARA FAVORECER LA RELACIÓN SOCIAL. ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y DE RELACIÓN SOCIAL. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

2.3.1. TÉCNICAS PARA FAVORECER LA RELACIÓN SOCIAL

Para favorecer el entrenamiento y desarrollo de habilidades sociales en nuestro trabajo con personas dependientes existen algunas **técnicas** que tendremos que utilizar: la empatía, la escucha activa, la retroalimentación, y la asertividad.

- La empatía

  Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. No se trata de pensar o sentir igual que la persona, no significa estar de acuerdo con el otro, sino de comprenderle y manifestarle que

entendemos cómo se siente, respetar sus sentimientos y razones para comportarse de una forma determinada.
Nos puede ayudar a enfatizar escuchar sin prejuicios, ser tolerante y paciente, plantearnos " ¿cómo me sentiría yo si..."
La empatía es importante en todas nuestras intervenciones, pero especialmente en el periodo de acogida y en situaciones de crisis.

- La escucha activa

  Es el principio más importante y difícil del proceso de la comunicación. No escuchar puede impedir que el mensaje se reciba. Escuchar requiere un esfuerzo. La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación, muchas veces se confunde oír y escuchar. Oír es percibir el sonido pero escuchar supone entender, comprender, y dar sentido a lo que se oye.

❖ Pautas Para escuchar de forma activa :

- Elegir un entorno agradable, con una temperatura e iluminación adecuada.
- Tener una actitud abierta y positiva.
- Centrarse en la que la persona dice, dirigir la postura hacia él.
- Dejar pequeños silencios, lo cual le ayudará a pensar lo que nos dice.
- Evitar realizar preguntas a modo de interrogatorio, realizar preguntas de respuesta amplias. Las preguntas cerradas (si, no...) las utilizaremos para aclarar lo que hemos interpretado.
- Comprobar si hemos entendido repitiendo el mensaje con nuestras palabras.
- Resumir el mensaje.

❖ Obstáculos en la escucha activa

- Falta de atención.
- No permitir que la persona (emisor) termine de expresarse.
- Ambiente poco agradable.
- Situaciones de cansancio, sueño, enfermedad que afecten e interfieran.
- Interrumpir.
- Juzgar a la otra persona.
- Crear un debate, discutir.

- Dar soluciones antes de que termine de hablar.

- La Retroalimentación

  Significa que el mensaje se ha recibido, el receptor realizará una serie de señales que indican que entiende, que está o no de acuerdo.

  Los usuarios pueden tener la sensación de que nadie les presta atención cuando hablan, por lo que dejan de comunicarse. La retroalimentación les ayuda a saber que su mensaje está siendo escuchado.

- La asertividad

  Supone ser capaz de defender los propios derechos, así como de expresar opiniones y sentimientos de forma adecuada, sin vulnerar los derechos del otro. Una conducta asertiva se caracteriza por respetar a los demás y respetarse a uno mismo; expresar las ideas de forma directa, y tener sentimientos de seguridad.

Estas técnicas las utilizará el técnico de ayuda a domicilio en su trabajo diario con las personas con dependencia, pero también podrá enseñarles a ellos a practicarlas. **Estas técnicas podemos emplearlas a la hora de**: iniciar una conversación, mantener conversaciones y finalizar las conversaciones.

a) **Iniciar conversaciones**: es importante elegir el momento adecuado, saber si la persona está abierta a una conversación. Existen diferentes formas de iniciar una conversación, como por ejemplo: ¿qué tal se encuentra hoy?; "parece que va a hacer frío". Cuando el usuario esté realizando alguna tarea comentar " está quedando bien..."

b) **Mantener conversaciones**: facilitaremos la continuidad de la conversación realizando preguntas abiertas a través de las que el usuario nos pueda contar vivencias, gustos, opiniones y así nosotros poderle mostrar nuestro interés.

c) **Finalizar conversaciones** utilizando formadas adecuadas para cerrar la conversación, para despedirnos, para acordar otro encuentro...

2.3.2. ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y DE RELACIÓN SOCIAL. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Como ya hemos explicado al inicio del tema, las personas que reciben atención en el domicilio ven afectadas sus relaciones sociales. Si tienen movilidad reducida, verán disminuido el número y la frecuencia de los contactos con otras personas (dificultades que implican los traslados). Por otro lado, el apoyo a

domicilio genera nuevos apoyos sociales que ayudarán a mantener las relaciones ya existentes y promover nuevas formas de relación.

Las actividades de acompañamiento se plantean como una forma de apoyar a las redes naturales de la persona con dependencia en lugar de sustituirlas. Estas actividades se denominan de **"acompañamiento"** porque requieren la participación del usuario. El es quien debe de ser el protagonista de las actividades y de las relaciones que establezca. El papel del profesional está en acompañar en ese proceso, en dar pautas, en favorecer encuentros, momentos, espacios, pero no puede ser un sustituto de las redes sociales de la persona con dependencia.

Podemos distinguir **3 tipos de intervenciones de acompañamiento**:

a) Intervenciones individuales aquellas que se desarrollan de forma individual con la persona con dependencia. Por ejemplo, conversaciones sobre temas de interés, leer juntos un libro , prensa o revista, escuchar la radio, comentar noticias.

b) Intervenciones dirigidas a mantener y fomentar la relación con personas allegadas, por ejemplo, realizar llamadas de teléfono a familiares, escribir cartas a amigos lejanos e incluso entrenar en medios como internet, correo electrónico... Además se facilitará el contacto personal con esas personas si es posible (por ejemplo, facilitar que esas personas acudan al domicilio a visitarlo).

c) Intervenciones orientadas a preservar y fomentar las relaciones con su entorno, por ejemplo, acompañar a participar en actividades comunitarias de su interés, como acudir a centros de convivencia de mayores, asociaciones, celebraciones religiosas, actividades recreativas, ferias, festejos, etc..

Algunas estrategias o pautas para poner en práctica estas intervenciones de acompañamiento:

- Establecer una relación de confianza.
- Utilizar una comunicación no verbal adecuada para transmitir cercanía y seguridad.
- Saber acompañar (estar atento a sus necesidades, saber escuchar..)
- Reconocer su dignidad (es importante dirigirse al usuario con respeto, mostrándole nuestra intención de ayudar, no de quitarle autoridad).
- Reforzar lo positivo, elogiar todas aquellas iniciativas por relacionarse.

2.4. MEDIOS Y RECURSOS.

2.4.1. APLICACIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Algunas personas que reciben atención en sus domicilios pueden tener dificultades para mantener la relación con los miembros de su red social, bien sea a consecuencia de sus déficits, o bien porque la persona ha ido perdiendo su capacidad para salir de casa y relacionarse en lugares diferentes a su domicilio.

Las nuevas **Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)** pueden ayudar a las personas con dependencia que tienen dificultades para comunicarse con los que les rodean en su vida diaria (por ejemplo a través de la telefonía móvil), pero también les permite el acceso a la información (internet) o a establecer contacto con otras personas, ampliando así las posibilidades de relación. Es por ello que la cultura tecnológica debería estar al alcance de todas las personas. Sin embargo, hoy en día existen dificultades de acceso a la información y a estas tecnologías por parte del colectivo de personas mayores en situación de dependencia. Barreras de tipo económico, de conocimiento específico, de accesibilidad.

La **telefonía móvil** les permite comunicarse con aquellas personas que deseen cuando quieran, sin tener que solicitar este servicio. Además existen teléfonos móviles adaptados a las necesidades de diferentes colectivos:

- Para personas ciegas: les permite escuchar los mensajes de texto recibidos, menús del móvil adaptados.
- Para personas sordas: indicadores luminosos de llamada, vibración..
- Para personas con poca motricidad fina: terminales de fácil manejo, dispositivos de manos libres...

Igualmente, para el manejo de los ordenadores y el uso de internet, también existen ayudas técnicas permitiendo así el acceso de todas las personas a los recursos.

Por tanto, es preciso tener en cuenta las limitaciones que la persona presenta con el fin de adaptar estas nuevas tecnologías a sus capacidades.

Algunos dispositivos y adaptaciones que facilitan la comunicación:

- Para personas con discapacidad motora

- Adaptaciones para la velocidad y la secuencia de las pulsaciones.

- Carcasas rígidas con el fin de compensar temblores o movimientos involuntarios.
- Miniteclados para una sola mano.
- Licornios, cabezales para usar el ordenador con movimientos de cabeza.
- Ratones y pulsadores adaptados.



Licornio



Ratón adaptado

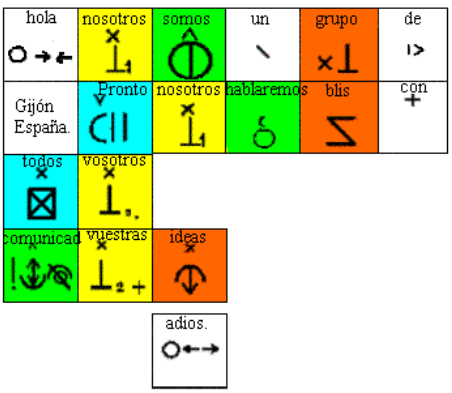
- <u>Para personas con parálisis cerebral:</u>

- Uso de pantalla táctil.
- Teclado con celdas grandes.
- Empleo de comunicadores , lo que les permite realizar y enviar correos electrónicos con programas adaptados, los símbolos (Bliss, SPC..) pueden seleccionarse mediante sistema de barrido.

Comunicador Deltatalker



Correo electrónico con sistema Bliss



- Para personas con discapacidad visual :

- La **Tiflotecnología** se encarga de realizar las adaptaciones necesarias para hacer accesible el uso de las TIC a las personas ciegas o con déficit visual. Así por ejemplo, se han realizado impresoras en Braille, teclados con línea Braille, magnificadores de pantalla (para aprovechar el posible resto visual).





Muchas de las personas con las que vamos a intervenir, no están familiarizadas con el uso del ordenador e internet, vamos a explicar brevemente los **pasos a seguir en el manejo de estas herramientas:**

- Perder el miedo: muchas personas nos van a decir "No voy a saber", "seguro que lo rompo", esto no es para mi"... Hay que hacerles ver que el ordenador es una herramienta útil y que la inseguridad viene del desconocimiento, les tranquilizaremos diciendo "si algo se rompe, seguro que puede arreglarse". El objetivo es que les resulte emocionante, divertido, práctico.

- Asegurarnos que sea accesible: Entrenar a los usuarios en el manejo de la herramienta.

- Facilitar el acceso a talleres de iniciación: procesamiento de textos, imágenes, presentaciones.

- Hacer uso del chat (conversaciones con personas de fuera del domicilio)., foros, correo electrónico (enviar cartas y fotografías a familiares y amigos), blogs...

2.4.2. ASOCIACIONISMO

Otra forma de interactuar con el entorno próximo es a través de las asociaciones. La asociación es un grupo de personas que comparten objetivos, intereses y actividades comunes.

El hecho de formar parte de una asociación permite a la persona sentirse integrada en un grupo con personas con intereses comunes, en condiciones de igualdad, lo cual tiene beneficios para su autoestima, además de suponer un estímulo para establecer relaciones interpersonales.
Las asociaciones de personas afectadas por una misma situación permiten intercambiar informaciones útiles, recibir asesoramiento en temas legales y económicos, compartir experiencias y temores, y realizar actividades recreativas diversas.

También resultan importantes para los familiares, ya que en ellas pueden encontrar información sobre la dolencia de la persona con dependencia, además de conocer a otros familiares de afectados con quienes poder hablar, aprender de experiencias ajenas y compartir el día a día.

En la actualidad se constata la existencia de un número cada vez mayor de personas en situación de dependencia física y sensorial comprometidas con el voluntariado y el compromiso social, quienes han encontrado un espacio para ayudar a los demás gracias a la disponibilidad de su tiempo libre y el mantenimiento de sus capacidades personales.

Por otro lado, distintas organizaciones de voluntariado prestan apoyo en la atención social a las personas en situación de dependencia que lo necesitan: tareas de acompañamiento, gestiones, actividades de contenido socioeducativo...

2.4.3. RECURSOS DEL ENTORNO Y VIAS DE ACCESO

Además de las asociaciones existen otros **recursos de la comunidad** a los que se puede acceder como participante de ellos, sin necesidad de asociarse.
Algunos están dirigidos a colectivos concretos (personas mayores, personas con discapacidad, ...) pero otros están abiertos a la población en general, éstos favorecen la integración social y la normalización de las personas con dependencia. Entre ellos podemos señalar actividades de expresión (como baile, teatro, música) actividades culturales (idiomas, tertulias,...) actividades deportivas (yoga, taichí, gimnasia adaptada) y talleres recreativos (pintura, manualidades..). El acceso a estos talleres suele ser a través de los **centros municipales de servicios sociales, casas de cultura...**

Otra opción para acceder a los recursos fuera del domicilio es a través del **voluntariado social**. La vía de acceso a este recurso suele ser mediante el contacto con las asociaciones o entidades que lo ofrezcan. Este servicio de voluntariado nunca debe suplir las tareas del profesional de atención domiciliaria.

Es importante que el técnico de apoyo a domicilio conozca los recursos disponibles en el entorno y las vías de acceso a los mismos, con el fin de que el usuario se mantenga activo e integrado en su entorno, conservando sus habilidades comunicativas y relacionales. El técnico deberá poner en conocimiento del usuario al que apoya la existencia de estos recursos, e incluso acompañarle en las gestiones pertinentes para el acceso a los mismos.

3. PRESTACIÓN DE ORIENTACIÓN A LA PERSONA DEPENDIENTE Y SUS CUIDADORES PRINCIPALES

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN APLICADOS A LAS SITUACIONES DOMICILIARIAS

Antes de realizar una intervención con una persona con dependencia, es imprescindible realizar una valoración previa para conocer las capacidades funcionales de la persona. Si no se realizase esta valoración podríamos estar prestando más ayuda de la necesaria, y por lo tanto aumentando la dependencia de la persona, o bien no atenderíamos a todas las necesidades del usuario.

Además es necesario realizar un seguimiento que nos permita conocer la evolución de la persona y si la intervención está siendo adecuada para conseguir los objetivos que nos hemos programado.

Para ello es preciso utilizar **técnicas de observación** y llevar un **registro** de los aspectos observados.

La observación es una técnica natural de obtención de información que consiste en observar, mirar atentamente, registrar y analizar aquellos aspectos sobre los que luego trabajaremos. A través de la observación podemos recoger mucha información que nos será útil para planificar la intervención que realizaremos con cada usuario. En el ámbito domiciliario la observación trata de captar cómo se desenvuelve la persona en su vida cotidiana y en su entorno.

3.1.1. OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN

Los objetivos de la observación en las situaciones domiciliarias son:

- Recoger información sobre las capacidades funcionales de la persona con dependencia.
- Disponer de datos sobre las actividades en las que la persona tiene más dificultades para realizarlas.

- Valorar la evolución funcional del usuario a lo largo de un tiempo.
- Recoger información sobre factores psicológicos, familiares y emocionales que puedan influir en esta evolución.

3.1.2. TIPOS DE TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN

- **Estructurada**: En este tipo de observación se definen con anterioridad aspectos que se desean analizar. La observación tiene un objetivo claro, definido y concreto. El observador define y delimita qué va a observar y para qué. Debe estar abierto a captar de forma espontánea todo aquello que pueda surgir.

- **No estructurada**: Este tipo de observación no tiene intención ni objetivo definido ni preparación previa. Se trata de observar sin concretar con anterioridad los aspectos que se van a observar. Se examina la situación y se anota lo que nos ha llamado la atención. Permite fijarse en aspectos que antes no se habían tenido en cuenta. Tiene el inconveniente de pasar por alto aspectos importantes.

El profesional de atención domiciliaria tiene un papel privilegiado en la observación de la capacidad funcional de la persona, ya que mantiene un contacto continuado y frecuente con ella.

3.1.3. INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA LA OBSERVACIÓN:

.

a) El **diario de campo** es un cuaderno en el que el profesional va redactando lo observado en su trabajo con una periodicidad que se establece previamente (puede ser diaria, dos veces por semana, semanal, quincenal...). Permite recoger los aspectos más llamativos de una situación. Antes de cada observación es importante anotar la fecha y la hora, y que el registro se realice seguido de la observación, puesto que si lo dejamos para otro momento, puede haber cambios en los registros.

b) Las **fichas de registro**: son instrumentos prediseñados donde vienen diseñados los aspectos a observar. Estas fichas deben ser sencillas y fáciles de completar para que el profesional pueda completarlas sin esfuerzo. Estas fichas de registro facilitan la observación estructurada, ya que el observador conoce previamente los aspectos a observar, sólo tiene que completarlas con sus impresiones.

Tanto el diario de campo como las fichas de registro deben cumplimentarse con la menor brevedad de tiempo posible, para ser exacto y no olvidar aspectos relevantes.

Posteriormente con los datos registrados se realizará una valoración entre el profesional y la entidad responsable del servicio de atención domiciliaria, permitiendo ajustar o modificar los objetivos planificados, mejorando así las intervenciones con los usuarios.

Ejemplo de una ficha de registro y seguimiento de actividades:

Usuario.....Fecha de realización.....
Profesional.....Incio del servicio.....Valoración anterior.....

ACTIVIDADES	periodicidad					Implicación del usuario						
	CD	DA	F	O	N	DT	MA	AL	S	IT	PC	OBS
Aseo por partes en la cama, cambio de pañal y vestido												
Movilización de la cama a silla de ruedas con grúa												
Limpieza de baño												
Preparar y dar desayuno												
Limpieza y arreglo de dormitorio												
Limpieza de estancias comunes												
Apoyo en tareas esporádicas												
Paseos en silla de ruedas												
Otros factores influyentes (familiares, sociales, sanitarios, económicos...)												
Observaciones												
Valoración												
Recomendaciones												
CD (cada día) **DA** (todos los días) **F** (frecuentemente) **O** (ocasionalmente) **N** (nunca) **DT** (dependencia total) **MA** (mucha ayuda) **AL** (ayuda limitada) **S** (supervisión) **IT** (independencia total) **PC** (podría colaborar pero no lo hace)												

3.1.4. LIMITACIONES Y VENTAJAS DE LA OBSERVACIÓN

La observación, al igual que todas las técnicas de investigación, presenta limitaciones y ventajas:

- Limitaciones: Es posible que la conducta concreta que se quiere observar no se presente en el momento de la evaluación.
- Ventajas:
  - Posibilita la obtención de información de los hechos tal y como ocurren en la realidad y en el entorno real.
  - Posibilita atender a conductas que en otras circunstancias no serían relevantes.
  - Existen situaciones en las que el análisis sólo es posible realizarlo mediante la observación.
  - No es precisa la colaboración de la persona objeto de observación.

3.2. LA OBSERVACIÓN Y EL REGISTRO DE LA EVOLUCIÓN FUNCIONAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN

Existen diferentes pruebas o escalas de valoración para evaluar y registrar cuál es el estado funcional y cognitivo de la persona, determinar cuál es su grado de dependencia en la realización de las AVD. Las más utilizadas son: Indice de Katz, Indice de Barthel y escala de incapacidad de la Cruz Roja para las AVD Básicas. Escala de Lawton y Brody para las AVD Instrumentales. Mini Examen Cognitivo de Lobo y GDS de Reisberg para determinar el grado de deterioro cognitivo.

ESCALAS MÁS UTILIZADAS PARA LA VALORACIÓN FUNCIONAL

ABVD (BASICAS)	- Indice de Katz - Índice de Barthel - Cruz Roja
AIVD (INSTRUMENTALES)	- Escala Lawton y Brody
DETERIORO COGNITIVO	- Mini Examen Cognitivo de LOBO (MEC) - GDS Reisberg

3.2.1. PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ABVD

Las escalas más utilizadas para evaluar las Actividades Básicas de la Vida Diaria son: (como en la unidad formativa 119, punto 2.12.2)

a) **Índice de Katz**: valora 6 ítems: bañarse, vestirse, usar el retrete, movilidad, continencia y alimentación. Se valora cada ítem con 1 pto si la persona realiza la tarea de forma independiente o con poca ayuda, 0 pto si no lo hace sola o precisa mucha ayuda. En función de la puntuación obtenida se clasifica al usuario desde la máxima independencia (grupo A) a la máxima dependencia (grupo G). Es una escala de aplicación fácil, rápida y sencilla y muy extendida para la aplicación de personas que son atendidas en el domicilio.

b) **Escala de Barthel:** Es la más utilizada internacionalmente. Evalúa 10 tipos de actividades (comer, lavarse, vestirse, arreglarse, deposición, micción, usar el WC., traslado al sillón o cama, deambulación y subir y bajar escaleras) y clasifica cinco grupos de dependencia. Se puntúa de 0 a 100, y en función de los resultados se clasifica en Dependencia total (puntuación menor de 20), dependencia grave (de 20 a 35), dependencia moderada (de 40 a 55) y dependencia leve (igual o mayor de 60).

c) **Escala de incapacidad de la Cruz Roja:** de fácil aplicación, consta de dos subescalas, una para valorar la incapacidad física y otra para valorar la incapacidad psíquica. Permite clasificar a las personas en 6 estadios, desde completamente independiente 0, hasta 5 que corresponde a la máxima dependencia.

3.2.2. PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AIVD

Para evaluar las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria se utiliza la **Escala de Lawton y Brody**: De fácil aplicación, para cada item se ofrecen entre 3 y 5 opciones de respuesta, hay que elegir la más ajustada para las capacidades del usuario. Cada área se valora entre 0 y 1 pto y la suma final estará entre 8 puntos (máxima independencia) y 0 puntos (dependencia total).

3.2.3. PARA DETERMINAR EL GRADO DE DETERIORO COGNITIVO

a) **Mini Examen Cognitivo de Lobo:** Se trata de un instrumento sencillo (aplicación de 10 minutos), consta de preguntas para la valoración de diferentes áreas cognitivas: orientación, fijación, concentración, cálculo, memoria, lenguaje y construcción.

b) La **escala GDS de Reisberg** se utiliza también para medir el grado de deterioro global de la persona, se emplea principalmente con personas que tienen asociado problemas de demencias. Establece 7 estados cognitivos posibles desde GDS-1 (ausencia de deterioro cognitivo), hasta GDS-7 (deterioro cognitivo muy grave).

Estas son las escalas a las que se ha hecho referencia:

INDICE DE KATZ (ABVD)

LAVADO

- ☐ No recibe ayuda (entra y sale de la bañera por sí mismo, si ésta es su forma habitual de bañarse).
- ☐ Recibe ayuda en la limpieza de sólo una parte de su cuerpo (p. ej., espalda o piernas).
- ▩ Recibe ayuda en el aseo de más de una parte de su cuerpo o ayuda al entrar y salir de la bañera.

VESTIDO

- ☐ Coge la ropa y se viste completamente sin ayuda.
- ☐ Sin ayuda, excepto para atarse los zapatos.
- ▩ Recibe ayuda para coger la ropa o ponérsela, o permanece parcialmente vestido.

USO DEL RETRETE

- ☐ Va al retrete, se limpia y se ajusta la ropa sin ayuda (puede usar bastón, andador o silla de ruedas). Puede usar orinal o bacinilla por la noche, vaciándolo por la mañana.
- ▩ Recibe ayuda para ir al retrete, limpiarse, ajustarse la ropa o en el uso nocturno del orinal.
- ▩ No va al retrete.

MOVILIZACIÓN

- ☐ Entra y sale de la cama. Se sienta y se levanta sin ayuda (puede usar bastón o andador).
- ▩ Entra y sale de la cama, se sienta y se levanta de la silla con ayuda.
- ▩ No se levanta de la cama.

CONTINENCIA

- ☐ Controla completamente ambos esfínteres.
- ▩ Incontinencia ocasional
- ▩ Necesita supervisión. Usa sonda vesical o es incontinente.

ALIMENTACIÓN

- ☐ Sin ayuda.
- ☐ Ayuda sólo para cortar la carne o untar el pan.
- ▩ Recibe ayuda para comer o es alimentado parcial o completamente usando sondas o fluidos intravenosos.

☐ Independiente. ▩ Dependiente.

VALORACIÓN

A. INDEPENDIENTE EN TODAS LAS FUNCIONES.
B. INDEPENDIENTE EN TODAS, SALVO EN UNA DE ELLAS.
C. INDEPENDIENTE EN TODAS, SALVO LAVADO Y OTRA MÁS.
D. INDEPENDIENTE EN TODAS, SALVO LAVADO VESTIDO Y OTRA MÁS.
E. INDEPENDIENTE EN TODAS, SALVO LAVADO, VESTIDO, USO DEL INODORO Y OTRA MÁS.
F. INDEPENDIENTE EN TODAS, SALVO LAVADO, VESTIDO, USO DEL INODORO, MOVILIZACIÓN Y OTRA MÁS.
G. DEPENDIENTE EN LAS SEIS FUNCIONES.

OTRAS. DEPENDIENTE AL MENOS EN DOS FUNCIONES, PERO NO CLASIFICABLE COMO C, D, E o F.

Figura 4. Índice de Katz.

INDICE DE BARTHEL (ABVD)

Parámetro	Situación del paciente	Puntuación
Total:		
Comer	- Totalmente independiente - Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc. - Dependiente	10 5 0
Lavarse	- Independiente: entra y sale solo del baño - Dependiente	5 0
Vestirse	- Independiente: capaz de ponerse y de quitarse la ropa, abotonarse, atarse los zapatos - Necesita ayuda - Dependiente	10 5 0
Arreglarse	- Independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc. - Dependiente	5 0
Deposiciones (valórese la semana previa)	- Continencia normal - Ocasionalmente algún episodio de incontinencia, o necesita ayuda para administrarse supositorios o lavativas - Incontinencia	10 5 0
Micción (valórese la semana previa)	- Continencia normal, o es capaz de cuidarse de la sonda si tiene una puesta - Un episodio diario como máximo de incontinencia, o necesita ayuda para cuidar de la sonda - Incontinencia	10 5 0
Usar el retrete	- Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse y ponerse la ropa... - Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia solo - Dependiente	10 5 0
Trasladarse	- Independiente para ir del sillón a la cama - Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo - Necesita gran ayuda, pero es capaz de mantenerse sentado solo - Dependiente	15 10 5 0

Parámetro	Situación del paciente	Puntuación
Deambular	- Independiente, camina solo 50 metros - Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 metros - Independiente en silla de ruedas sin ayuda - Dependiente	15 10 5 0
Escalones	- Independiente para bajar y subir escaleras - Necesita ayuda física o supervisión para hacerlo - Dependiente	10 5 0

Máxima puntuación: 100 puntos (90 si va en silla de ruedas)

Resultado	Grado de dependencia
< 20	Total
20-35	Grave
40-55	Moderado
≥ 60	Leve
100	Independiente

ESCALA CRUZ ROJA (ABVD)

Grados de incapacidad FÍSICA

Grado 0	Se vale por sí mismo y anda con normalidad
Grado 1	Realiza las AVD Deambula con alguna dificultad Continencia normal
Grado 2	Cierta dificultad en las AVD, necesita ayuda Deambula con bastón u otro medio de apoyo Continencia normal o rara incontinencia
Grado 3	Grave dificultad en bastantes AVD Deambula con dificultad, ayudado por una persona Incontinencia ocasional
Grado 4	Necesita ayuda para cualquier AVD
Grado 5	Inmovilidad en cama o sillón Precisa cuidados de enfermería constantes Incontinencia total

Grados de incapacidad Mental

Grado 0	Completamente normal
Grado 1	Presenta trastornos de la memoria, pero puede mantener una conversación normal
Grado 2	Ciertas alteraciones de la memoria y a veces de la orientación La conversación razonada posible pero imperfecta Trastornos del carácter Algunas dificultades para el autocuidado
Grado 3	Alteraciones graves de memoria y orientación Imposible mantener una conversación coherente Trastornos evidentes del comportamiento Graves dificultades para el autocuidado
Grado 4	Desorientación completa Claras alteraciones mentales, etiquetadas como demencia Incontinencia habitual
Grado 5	Demencia avanzada Vida vegetativa con signos de agitación Incontinencia total

ESCALA DE LAWTON Y BRODY (AIVD)

Escala de actividades instrumentales de la vida diaria

Aspecto a evaluar	Puntuación
Capacidad para usar el teléfono:	asignar:
- Utiliza el teléfono por iniciativa propia	1
- Es capaz de marcar bien algunos números familiares	1
- Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar	1
- No es capaz de usar el teléfono	0
Hacer compras:	asignar:
- Realiza todas las compras necesarias independientemente	1
- Realiza independientemente pequeñas compras	0
- Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra	0
- Totalmente incapaz de comprar	0
Preparación de la comida:	asignar:
- Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente	1
- Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes	0

- Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada - Necesita que le preparen y sirvan las comidas	0 0
Cuidado de la casa: - Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados) - Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas - Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza - Necesita ayuda en todas las labores de la casa - No participa en ninguna labor de la casa	asignar: 1 1 1 1 0
Lavado de la ropa: - Lava por sí solo toda su ropa - Lava por sí solo pequeñas prendas - Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro	asignar: 1 1 0
Uso de medios de transporte: - Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche - Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte - Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona - Sólo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros - No viaja	asignar: 1 1 1 0 0
Responsabilidad respecto a su medicación: - Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta - Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente - No es capaz de administrarse su medicación	asignar: 1 0 0
Manejo de sus asuntos económicos: - Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo - Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras, bancos... - Incapaz de manejar dinero	asignar: 1 1 0
Puntuación total:	

La información se obtendrá de un cuidador fidedigno. Se puntúa cada área conforme a la descripción que mejor se corresponda con el sujeto. Por tanto, cada área puntúa un máximo de **1 punto** y un mínimo de **0 puntos**. La máxima dependencia estaría marcada por la obtención de **0 puntos**, mientras que una suma de **8 puntos** expresaría una independencia total.

Esta escala es más útil en mujeres, ya que muchos varones nunca han realizado algunas de las actividades que se evalúan

MINI EXAMEN COGNITIVO DE LOBO

ORIENTACIÓN	PUNTOS
"Dígame el: Día....fecha....mes....estación...año....	.....(5)
Dígame el : lugar...planta...ciudad....provincia...nación...	.....(5)
FIJACIÓN	
"Repita estas tres palabras: euro, caballo, manzana"	.....
CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO	
" Si tiene 30 euros	

El MEC de Lobo ((http://www.hipocampo.org)

Es la versión adaptada y validada en España del **MMSE (*Mini-Mental State Examination*) de Folstein.** Se trata de un test de cribado de demencias, útil también en el seguimiento evolutivo de las mismas.

Existen dos versiones, de 30 y de 35 puntos respectivamente, siendo la de 30 puntos un instrumento más útil para comparaciones internacionales. Tanto en una versión como en la otra los ítems están agrupados en 5 apartados que comprueban orientación, memoria de fijación, concentración y cálculo, recuerdo diferido, y lenguaje y construcción.

Por ejemplo, en el área de orientación y dentro de la subsección de «ORIENTACIÓN EN EL TIEMPO», se hacen al paciente preguntas como: «¿Cuál es la fecha?» para comprobar su grado de orientación.
Para la comprobación de la «MEMORIA DE FIJACIÓN» (o memoria inmediata) se intenta que el sujeto aprenda tres palabras, diciéndole: «Ahora, por favor, le voy a pedir que repita estas tres palabras: euro - Caballo - Manzana».
Se recomienda que entre palabra y palabra se deje una pausa de 1 segundo aproximadamente, y se le repite la serie hasta que la aprenda, aunque en este apartado sólo se registran las respuestas obtenidas tras la primera serie. La intención de las repeticiones es que se aprenda las palabras si le es posible, porque se le volverán a preguntar en el apartado de memoria diferida.
En el área de lenguaje y construcción, se comprueba la posible presencia de trastornos afásicos, de apraxia ideatoria, de apraxia de construcción... A modo de ejemplo, algunos ítems de este área son:
Nombrar
Mostrando un bolígrafo: «¿Qué es esto?»
Lectura
«Por favor, lea esto y haga lo que dice». [Muéstrele el impreso de estímulo con la frase: «CIERRE LOS OJOS»].
La versión de 35 puntos
La versión de 35 puntos añade un ítem de dígitos, de 3 puntos, en el apartado de «Concentración y cálculo»:

«Repita los números que voy a decirle: 5-9-2 (hasta que se los aprenda, y contando los intentos, nº.....); Ahora repita los números hacia atrás, empezando por el último».
y otro de abstracciones, de 2 puntos, en el apartado de «Lenguaje y construcción»:
«Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad? Se parecen en que son frutas. ¿Qué son (o en qué se parecen) el rojo y el verde?¿Qué son (o en qué se parecen) un perro y un gato?».

El punto de corte para demencia se establece habitualmente en 24 puntos. Si hay que anular algún punto (a causa de analfabetismo, ceguera, hemiplejia...) se recalcula proporcionalmente. Por ejemplo, 21 puntos sobre 26 posibles en la versión de 30 puntos equivaldrían a un resultado de 24 puntos (se redondea al entero más próximo).

GLOBAL DETERIORATION SCALE (ESCALA DE DETERIORO GLOBAL) DE REISBERG

(http://www.hipocampo.org/reisberg.asp)

GDS-1, ausencia de alteracion cognitiva

(Miniexamen cognoscitivo -MEC- de Lobo entre 30 y 35 puntos). Se corresponde con el individuo normal:
Ausencia de quejas subjetivas.
Ausencia de trastornos evidentes de la memoria en la entrevista clínica.

GDS-2, disminución cognitiva muy leve

(MEC de Lobo entre 25 y 30 puntos). Se corresponde con el deterioro cognitivo subjetivo:
Quejas subjetivas de defectos de memoria, sobre todo en:
a) Olvido de dónde ha colocado objetos familiares.
b) Olvido de nombres previamente bien conocidos.
No hay evidencia objetiva de defectos de memoria en el examen clínico.
No hay defectos objetivos en el trabajo o en situaciones sociales.
Hay pleno conocimiento y valoración de la sintomatología.

GDS-3, defecto cognitivo leve

(MEC de Lobo entre 20 y 27 puntos). Se corresponde con el deterioro cognitivo leve:
Primeros defectos claros: manifestaciones en una o más de estas áreas:
a) El paciente puede haberse perdido en un lugar no familiar.
b) Los compañeros detectan rendimiento laboral pobre.
c) Las personas más cercanas detectan defectos en la evocación de palabras y nombres.
d) Al leer un párrafo de un libro retiene muy poco material.

e) Puede mostrar una capacidad muy disminuida en el recuerdo de las personas nuevas que ha conocido.
f) Puede haber perdido o colocado en un lugar erróneo un objeto de valor.
g) En la exploración clínica puede hacerse evidente un defecto de concentración.

Un defecto objetivo de memoria únicamente se observa con una entrevista intensiva.
Aparece un decremento de los rendimientos en situaciones laborales o sociales exigentes.
La negación o desconocimiento de los defectos se hace manifiesta en el paciente.
Los síntomas se acompañan de ansiedad discreta-moderada.

GDS-4, defecto cognitivo moderado

(MEC de Lobo entre 16 y 23 puntos). Se corresponde con una demencia en estadio leve:
Defectos claramente definidos en una entrevista clínica cuidadosa en las áreas siguientes:
a) Conocimiento disminuido de los acontecimientos actuales y recientes.
b) El paciente puede presentar cierto déficit en el recuerdo de su propia historia personal.
c) Defecto de concentración puesto de manifiesto en la sustracción seriada de sietes.
d) Capacidad disminuida para viajes, finanzas, etc.
Frecuentemente no hay defectos en las áreas siguientes:
a) Orientación en tiempo y persona.
b) Reconocimiento de personas y caras familiares.
c) Capacidad de desplazarse a lugares familiares.
Incapacidad para realizar tareas complejas.
La negación es el mecanismo de defensa dominante.
Disminución del afecto y abandono en las situaciones más exigentes.

GDS-5, defecto cognitivo moderado-grave

(MEC de Lobo entre 10 y 19 puntos). Se corresponde con una demencia en estadio moderado:
El paciente no puede sobrevivir mucho tiempo sin alguna asistencia.
No recuerda datos relevantes de su vida actual: su dirección o teléfono de muchos años, los nombres de familiares próximos (como los nietos), el nombre de la escuela, etc.
Es frecuente cierta desorientación en tiempo (fecha, día de la semana, estación, etc.) o en lugar.
Una persona con educación formal puede tener dificultad contando hacia atrás desde 40 de cuatro en cuatro, o desde 20 de dos en dos.
Mantiene el conocimiento de muchos de los hechos de mayor interés concernientes a sí mismo y a otros.
Invariablemente sabe su nombre, y generalmente el de su esposa e hijos.
No requiere asistencia en el aseo ni en la comida, pero puede tener cierta dificultad en la elección de los vestidos adecuados

GDS-6, defecto cognitivo grave
(MEC de Lobo entre 0 y 12 puntos). Se corresponde con una demencia en estadio moderadamente grave:
Ocasionalmente puede olvidar el nombre de la esposa, de la que, por otra parte, depende totalmente para sobrevivir.
Desconoce los acontecimientos y experiencias recientes de su vida.
Mantiene cierto conocimiento de su vida pasada, pero muy fragmentario.
Generalmente desconoce su entorno, el año, la estación, etc.
Puede ser incapaz de contar desde 10 hacia atrás, y a veces hacia adelante.
Requiere cierta asistencia en las actividades cotidianas.
Puede tener incontinencia o requerir ayuda para desplazarse, pero puede ir a lugares familiares.
El ritmo diurno está frecuentemente alterado.
Casi siempre recuerda su nombre.
Frecuentemente sigue siendo capaz de distinguir entre las personas familiares y no familiares de su entorno.
Cambios emocionales y de personalidad bastante variables, como:
a) Conducta delirante: puede acusar de impostora a su esposa, o hablar con personas inexistentes, o con su imagen en el espejo.
b) Síntomas obsesivos, como actividades repetitivas de limpieza.
c) Síntomas de ansiedad, agitación e incluso conducta violenta, previamente inexistente.
d) Abulia cognitiva, pérdida de deseos, falta de elaboración de un pensamiento para determinar un curso de acción propositivo.

GDS-7, defecto cognitivo muy grave
(MEC de Lobo = 0 puntos, impracticable). Se corresponde con una demencia en estadio grave:
Pérdida progresiva de las capacidades verbales. Inicialmente se pueden verbalizar palabras y frases muy circunscritas; en las últimas fases no hay lenguaje, únicamente gruñidos.
Incontinencia de orina. Requiere asistencia en el aseo y en la alimentación.
Se van perdiendo las habilidades psicomotoras básicas, como la deambulación.
El cerebro es incapaz de decir al cuerpo lo que ha de hacer. Frecuentemente aparecen signos y síntomas neurológicos generalizados y corticales.

Nota aclaratoria: La correlación entre el estadio GDS y la puntuación del MEC de Lobo es orientativa

3.2.4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN

A partir de la evaluación de las capacidades funcionales y cognitivas de la persona, se realiza la planificación de los objetivos a trabajar y las actividades de atención que se desarrollarán con él o por él.

Las **actividades de atención doméstica** que el cuidador puede realizar en el ámbito domiciliario son:

- Limpieza de estancias y mobiliario (limpiar el polvo, barrer, fregar el suelo, limpiar superficies altas, baños , cocina, vajilla...).
- Cuidado de la ropa (lavar, secar, planchar, pequeños arreglos de costura..).
- Elaboración y programación de comidas (seleccionar alimentos de acuerdo con las necesidades y preferencias, introducir hábitos saludables, preparación de comidas y cenas).
- Realización de compras domésticas (productos alimenticios, de limpieza y mantenimiento del hogar y de aseo personal, compra de la medicación)
- Pequeñas reparaciones domésticas (cambiar bombillas, colgar un cuadro..)

Las actividades de **atención personal:**

- Apoyo en la higiene personal (ducha, aseo, lavado de cabeza, peinado, lavado de dientes, afeitado, depilación...)
- Ayuda para la alimentación (ayudará si fuera necesario a la ingestión de alimentos y facilitará el uso de útiles adaptados y técnicas necesarias)
- Apoyo en el vestido (ayudará a seleccionar el vestuario adecuado al clima diario, prestará ayuda a vestir y desvestir apoyando en aquellas tareas que presente más dificultad).
- Cuidados personales especiales (cambio de pañal, control de la medicación, cuidado de la sonda, pequeñas curas, cambios posturales, ejercicios de rehabilitación).
- Apoyo a la movilización dentro del hogar.
- Otras actividades (reeducativas como entrenamiento de hábitos de autonomía personal, práctica de habilidades sociales..)

Con cada persona realizaremos las actividades oportunas, periódicamente se revisará la capacidad funcional y las necesidades de la persona. Las actividades serán registradas a través de diferentes instrumentos de observación.

4. EL AMBIENTE COMO FACTOR FAVORECEDOR DE LA AUTONOMÍA PERSONAL, COMUNICACIÓN Y RELACIÓN SOCIAL

Las características del domicilio en el que se desenvuelve la persona con dependencia influirán de forma importante en la realización de las actividades diarias, en la autonomía, en el bienestar y en la calidad de vida de la persona.

En su labor diaria de atención directa a la persona dependiente, el auxiliar domiciliario es quien mejor puede identificar las necesidades de apoyo que pudieran surgir en el desenvolvimiento cotidiano de las personas a las que asiste. Debe también conocer las **características ambientales** y los **elementos** que componen la vivienda (arquitectónico, distribución de espacios, mobiliario, ubicación..) para poder intervenir en ellos para facilitar la realización de las actividades de la vida diaria de forma más segura, sencilla e independiente para la persona; para facilitar la movilidad , minimizar el riesgo de caídas y ayudar a la orientación espaciotemporal de las personas.

Igualmente es importante tener en cuenta que el **domicilio** es un espacio **propio, íntimo y personal**, que se ha ido haciendo a lo largo de los años, por lo que si tenemos que introducir modificaciones debemos plantearlas como orientaciones para mejorar el bienestar de la persona; respetando siempre el hecho que el usuario decidirá si se realizan o no las modificaciones propuestas.

4.1. DISTRIBUCIÓN Y DECORACIÓN DE ESPACIOS

La vivienda es el espacio en el que la persona crea su propio entorno y desarrolla sus relaciones sociales más cercanas. Por lo tanto, la persona dependiente debe encontrar dicho ambiente adecuado a su situación: un ambiente que le garantice autonomía, seguridad, dignidad, confort, etc.

A la hora de **reorganizar la distribución de los espacios** es necesario considerar dos aspectos:

- las características físicas, psicológicas y funcionales del usuario
- La finalidad que se pretende conseguir en ese ambiente.

Es importante que la distribución de la vivienda favorezca la relación social pero es muy importante que el usuario tenga control sobre su **privacidad**. En el domicilio (que es un espacio privado) la privacidad está relacionada con la capacidad que ofrecen los espacios para regular una mayor o menor interacción social. Diferenciamos tres tipos de espacios:

a) Espacios **privados**: los dormitorios y el cuarto de baño
b) Espacios **públicos**: las zonas comunes del edificio (jardines, entrada al edificio, escaleras, pasillos, rellanos). En el interior del domicilio la sala de estar.
c) Espacios **semiprivados y semipúblicos**: vestíbulo, cocina y pasillos.

En un domicilio es importante respetar el área íntima y privada de la persona, donde pueda relajarse, descansar, pasar un tiempo a solas si lo desea; pero también debe de haber espacios que favorezcan las interacciones con otras personas. La distribución de las estancias facilitará o dificultará la movilidad de los usuarios*. Por ejemplo, una distribución en la que por unas habitaciones se*

acceda a otras dificultará la movilidad y puede causar desorientación. (distribución incorrecta).

Lo mismo ocurre con **el mobiliario**, por ejemplo las mesas pequeñas o auxiliares favorecen interacciones más cercanas; mientras que las mesas grandes (tipo comedor) fomentan relaciones más formales. En las estancias comunes (sala de estar) es importante que la distribución de los muebles permita sentarse y entablar conversaciones (sillones uno frente a otro, o entorno a una mesa auxiliar).

En **el baño**, lo que prima es la accesibilidad y la comodidad del usuario. Tenemos que procurar que la persona pueda mantener su privacidad de forma autónoma, por lo que tendremos que hacer que sea un espacio accesible. Deberemos evitar el exceso de elementos distractores (varios tipos de champú, diferentes tipos de crema) y los obstáculos que dificulten los movimientos. Tendremos en cuenta y evaluaremos el suelo, la ducha, el baño, los soportes y asideros... Puede ser preciso colocar alfombras antideslizantes en la bañera o ducha, grifos monomando, puertas que se puedan abrir desde fuera,...

En **la cocina,** al igual que en el resto de dependencias, es preciso garantizar su acceso y libertad de movimientos dejando la habitación libre de obstáculos. Se precisa atender la iluminación, las características y altura adecuada de los muebles y los electrodomésticos en función de las características de la dependencia de la persona...

En **el dormitorio**: Además de todo lo referente a movilidad... como en los casos anteriores, cabe destacar la altura adecuada de la cama y otros muebles, cajones, ... así como la colocación de elementos que faciliten la incorporación y las transferencias. La habitación tiene que ser espaciosa y favorecer que la persona decore este espacio con los objetos personales que prefiera (fotos, cuadros..), siempre teniendo en cuenta que no interfieran en la movilidad.

(consultar documentos pdf que se proponen en la web " Un baño a mi medida" " Un mundo horizontal" " Muéveme fácilmente"" La vida sobre ruedas")

Respecto al **mobiliario**, y con el objetivo de facilitar la movilidad autónoma del usuario se intentará:

- Situar los muebles o posibles obstáculos (si no es posible su eliminación) a un lado de la estancia con el fin de favorecer el paso y la movilidad.
- Procurar que los bordes de los muebles sean redondeados (o adaptarlos)y que no tengan salientes a diferentes alturas. También será importante que los muebles estén bien fijados, evitando que puedan volcarse si la persona se apoya sobre ellos.

- Que la anchura de las puertas permita el paso con silla de ruedas por si fuese necesaria.
- Limitar los muebles a los mínimos necesarios (siempre respetando las preferencias del usuario),

Las **condiciones ambientales**: luz, ruido, temperatura, ventilación, humedad, también forman parte del domicilio y pueden favorecer o dificultar las relaciones sociales y la autonomía personal.

Con respecto a la **relación con el mundo exterior**, se facilitará el contacto a través de cristaleras, ventanales etc. La presencia de zonas verdes, terrazas, patios son también favorecedores ya que permiten el contacto con elementos naturales (tocar plantas, ver árboles, escuchar pájaros, ver los cambios de los árboles en función de las estaciones, olor de las flores y la hierba...Todo ello contribuye al bienestar del usuario.

La decoración de los ambientes (los colores producen efectos en el estado de ánimo de las personas e influye en las relaciones interpersonales) es otro elemento que puede ser motivador para la persona con dependencia. La decoración tiene que ser equilibrada y funcional procurando transmitir una sensación acogedora. Los colores cálidos pero suaves y luminosos ayudan a conseguir esa sensación. Para espacios como la habitación se aconsejan tonos suaves para crear un ambiente tranquilo, como complemento podemos utilizar plantas o flores.

4.2. USO DE MATERIALES DOMÉSTICOS

En cuanto a los elementos y materiales cotidianos, deben eliminarse, organizarse o adecuarse a la situación de dependencia de la persona para que no impidan el mantenimiento de su independencia.

Con el fin de garantizar su seguridad, es preciso que no existan elementos que puedan provocar caídas o tropiezos y que faciliten la movilidad por la estancia (alfombras, cables, etc).

Para facilitar y garantizar la realización de las actividades de la vida diaria de manera independiente, existen en el mercado utensilios (productos de apoyo adaptados, antes llamadas ayudas técnicas) que favorecen la realización de estas actividades de forma fácil y segura. Deben ser utilizadas en función del grado de dependencia. Por citar algunas: Pinzas con ayuda para colocar calcetines y medias, abotonadores, elevador de W.C., cubiertos adaptados, reborde para platos, teléfonos con manos libres y teclas grandes, dispositivos con mensajes previamente grabados que se accionan con facilidad...

5. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

5.1. MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA PSICOSOCIAL EN SITUACIONES COTIDIANAS DEL DOMICILIO.

El fin último de la atención a las personas que presentan algún grado de dependencia es conservar y/o mejorar su autonomía e independencia . Por lo tanto, si una persona es capaz de realizar una actividad concreta o parte de ella por sí misma, conviene que la siga realizando aunque su ejecución no sea del todo satisfactoria, por lo que se le debe ofrecer la instrucción precisa para que la persona la ejecute de manera independiente.

Este trabajo realizado en cuanto a los hábitos y las actividades de la vida diaria, repercute de manera significativa en la vida de las personas en aspectos como mejora del estado funcional en general, aumento de la satisfacción con la vida, mejora de la autopercepción de la salud, aumento de la capacidad física, mejora de la vitalidad, de las relaciones sociales, la salud psicológica (tanto a nivel cognitivo como emocional)...

Consejos generales para afrontar la realización de las AVD:

- Mantener siempre la misma secuencia en la realización de las AVD, así como un mismo horario, y una buena estructuración.
- Mantener un entorno lo más estable posible, seguro, sencillo, facilitador, orientador, adaptado y tranquilo, tanto físico como familiar.
- Adelantarnos a sus necesidades, pero sin sobreprotegerles, y estimular su autonomía.
- Mantener y estimular las capacidades conservadas del individuo.
- Simplificar tempranamente y al máximo las tareas de autocuidado. Todas se descomponen en otras más fáciles que es posible que realicen sin ayuda. Repetir instrucciones en cada paso.
- Realizar actividad física adaptada diariamente o tan frecuente como sea posible.
- Dar tiempos de tranquilidad y relajación.
- Estimulación de aspectos cognitivos de la persona .
- Asesorarse acerca de los hábitos molestos, alteraciones del estado de ánimo, trastornos del comportamiento que acompañan a la enfermedad.
- Estimular el habla y cualquier comunicación con el exterior de una forma adecuada , sencilla y clara.
- Mantener un intercambio social aceptable.

- Buscar las actividades de ocio y tiempo libre más motivadoras y participativas para el enfermo.
- La seguridad propia y la de los demás es imprescindible y hay que buscarla siempre.
- Estar alerta ante el resto de enfermedades y de los déficit sensoriales (vista, oído, etc,), de las que no están libres.
- Normalizar las repercusiones de su conducta. Comprender su estado, su enfermedad. Ser flexibles y pacientes. La discusión aumenta su confusión.

Características del trabajo de mantenimiento de las AVD:

- La clave fundamental está en la motivación de la propia persona, su esfuerzo y colaboración son fundamentales. El auxiliar debe fomentarlas con su actitud reforzando y felicitando los logros y restando importancia a los fracasos, en previsión de la frustración que pueda aparecer.
- El entorno social (familiares y amigos) y el auxiliar domiciliario deben trabajar conjuntamente y en la misma línea.
- Las indicaciones y los trabajos que se realicen deben llevarse a cabo en un ambiente alegre y optimista.
- Se debe intentar cualquier mejora o recuperación, por pequeña que sea, ya que puede ser decisiva en la mejora o mantenimiento de la independencia.
- Es fundamental potenciar las capacidades y habilidades preservadas para poder compensar las parcialmente alteradas.

5.2. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

5.2.1. Intervención grupal

Algunos objetivos de intervención psicosocial requieren de esta técnica para poderse lograr. Por ejemplo, intervenciones concretas centradas en la ayuda mutua, el desarrollo de la solidaridad, de habilidades sociales, ...

5.2.2. Intervención y terapia familiar

La familia es la red de socialización primaria, y las relaciones entre sus miembros pueden influir en el estado de salud general de la persona dependiente.

5.3.3. **Técnicas de mediación**

Son especialmente importantes en situaciones donde entran en conflicto los intereses de distintas personas. En este contexto de personas mayores dependientes suelen ser necesarias en circunstancias como el desacuerdo entre distintos familiares ante una toma de decisión concreta... Se ponen en marcha procedimientos y técnicas de negociación que posibilitan reducir los conflictos aparecidos y avanzar en la resolución de problemas.

5.3. TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Ante un conflicto, una alteración de conducta determinada, es necesario actuar de la manera menos agresiva para la persona dependiente y del modo más adecuado para ella y el/la auxiliar. A veces será suficiente la negociación, pero otras este último deberá poner en práctica estrategias más elaboradas de modificación de comportamiento o pensamiento. Estas dependerán del tipo de dependencia que posea la persona.

5.3.1. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN

El objetivo de la negociación no es salir ganador ni llegar a un pacto equilibrado, sino conseguir un acuerdo que beneficie a ambas partes. Para lograrlo será necesario:

- Utilizar habilidades de comunicación, de autocontrol y de manejo de conflictos.
- Ser observador intentando comprender los puntos de vista del otro y no interpretar equivocadamente.
- Mantener el equilibrio entre la razón y las emociones.
- Crear un clima de empatía.
- No coaccionar
- Realizar la negociación en un ambiente cómodo.

5.3.2. HABILIDADES PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS O SITUACIONES DIFÍCILES

Ante un conflicto de intereses o situación incómoda, se debe intentar resolver el problema. Se trata de buscar la manera de lograr los propios objetivos teniendo en cuenta los de la otra persona, evitando caer en actitudes como ignorar el conflicto, buscar sólo los propios objetivos, evitar la discusión o no enfrentarse a él...

Para pedir un cambio de comportamiento a la persona dependiente conviene tener en cuenta:

- Describir el problema de forma concreta, sin juzgarlo, ni interpretarlo, ni ser acusador...
- Explicar cuáles son las consecuencias de esa conducta y plantear el problema en términos objetivos.
- Empatizar, anticipando las pegas, dificultades...("entiendo que si lo realizas tú tardas más tiempo...").
- Asumir la propia responsabilidad si la hay ("quizá no te he comentado la importancia que tiene el que realices la actividad por ti mismo"...)
- Pedir alternativas de cambio y/o proporcionarlas. Deben ser alcanzables y con un plazo de tiempo determinado para lograrlas.
- Reforzar la escucha y la disposición al cambio ("te agradezco que vayas a intentarlo")

5.3.3. ESTRATEGIAS EN EL MANEJO DE ALTERACIONES DE CONDUCTA

Las alteraciones de conducta son propias de determinadas enfermedades, especialmente las neurodegenerativas (por ejemplo, las demencias). La persona enferma no se comporta así de modo intencionado, por "fastidiar", sino Como consecuencia de la propia enfermedad, de cambios ambientales o incluso de nuestro propio comportamiento. Algunas alteraciones de las más frecuentes son:

- Agresividad:

El comportamiento agresivo puede deberse a distintos motivos, como sentimientos de inutilidad o fracaso, dolor oculto, cambios en la rutina cotidiana, efectos de alguna medicación, enfermedades (como procesos infecciosos).
Algunas estrategias de manejo: no gritarles o regañarles, desviar su atención hacia otras cosas (hablándole de manera pausada...), anticipar y prevenir las situaciones que puedan desencadenarla, explicar las actividades que se van a hacer y darles tiempo...

- Vagabundeo, deambulación errante:

En ocasiones, la persona con deterioro cognitivo permanece andando sin motivo aparente y sin rumbo fijo durante cierto tiempo y resulta complicado que se siente. Y cuando lo hace, al momento vuelve a deambular de un lado para otro...Este tipo de comportamiento puede deberse al aburrimiento, a la necesidad de actividad física, de acudir al cuarto de baño, por desorientación...
Ante este comportamiento el auxiliar debe procurar: facilitar un ejercicio o actividad controlada, mantener una rutina diaria, crear un entorno seguro sin barreras arquitectónicas, utilizar señales de orientación (con dibujos o letras por las distintas estancias de la casa...), no prestar atención a las caminatas, sino a otras actividades alternativas.

- Delirios:

Los delirios son falsas ideas que no se corresponden con la realidad. Ante su aparición, el auxiliar debe situar a la persona en un espacio conocido y familiar, escucharle para que se sienta atendido, no discutir ni darles la razón, ni llevarles la contraria sino dejar clara la intención de ayudar, buscar el lugar en el que esconde las cosas si tiene delirios de robo, distraerle, desviar su atención hacia cosas o actividades agradables, hacerle saber que el auxiliar se encargará de solucionar los problemas y de comprobar que todo está bien.

5.4. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

La modificación de conducta se basa en la teoría del aprendizaje conductista. Lograr el cambio de un comportamiento supone en primer lugar identificar y analizar la conducta no deseada, para aprender a responder de un modo más adaptativo y adecuado a los deseos de la persona dependiente a través de las distintas técnicas existentes.

Procedimientos y estrategias que se emplean en la modificación de conducta

- Desensibilización sistemática:

Consiste en presentar un estímulo que genera respuestas desagradables de forma gradual y en estado de relajación para ir sustituyendo progresivamente estas respuestas desagradables por otras neutras.

- Condicionamiento aversivo:

Se trata de asociar un comportamiento que deseamos no se lleve a cabo (gritar) con una consecuencia desagradable (recriminación).

- Condicionamiento operante:

Se basa en asociar consecuencias agradables o refuerzos a la realización de conductas previamente inexistentes o poco frecuentes.

- Aprendizaje vicario u observacional:

Se basa en la capacidad de encontrar refuerzos o consecuencias desagradables en la observación de la conducta de otros que se convierten en modelos por imitar.

Procedimientos y estrategias que se emplean para reducir o eliminar una conducta

- Extinción:

Consiste en la eliminación de las consecuencias que están manteniendo un comportamiento hasta que llegue a desaparecer. Es la estrategia más poderosa.

- Tiempo fuera:

Se trata de privar temporalmente a la persona de aquello que le refuerza la conducta,

- Retirada de atención:

Consiste en suspender totalmente la interacción una vez aparecida la conducta no deseada que se quiere modificar hasta que ésta desaparece.

- Sobrecorrección:

Se trata de hacer repetir una conducta a la persona tantas veces como sea necesario hasta conseguir la conducta deseada.

Cuando lo que se desea es **sustituir una conducta por otra**, de modo que la persona precisa del aprendizaje de otro patrón de comportamiento, se utiliza la **técnica del moldeamiento**, que consiste en descomponer una conducta determinada en pasos de forma que uno sea prerrequisito del siguiente. Esta técnica se utiliza sobre todo en la instauración de comportamientos que habían desaparecido, en la corrección de errores, en el aprendizaje de una habilidad, en el entrenamiento de habilidades y comportamientos complejos y en el control de hábitos inadecuados.

5.5. INTERVENCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA RELACIÓN SOCIAL, EN LA RESOLUCIÓN DE GESTIONES Y EN EL ENTORNO FAMILIAR

El apoyo en la relación social persigue los siguientes objetivos:

- Incrementar el nivel de habilidades y capacidades adaptativas (funcionales) de la persona.
- Favorecer el desarrollo personal, social y emocional.
- Reforzar la autoestima y el sentimiento de utilidad de la persona.

Las tareas del auxiliar en este ámbito deben ser de tipo formativo y educativo, para facilitar y posibilitar a la persona en situación de dependencia las interrelaciones con su entorno social. Lo realizará a través de distintos recursos de apoyo (personales, tecnológicos,...), y funciones (seguridad, planificación económica, ayuda en el hogar, acceso a otros recursos, apoyo sanitario...) .

5.6. MALOS TRATOS A LOS ANCIANOS

El maltrato al anciano emerge como problema social hace pocos años porque siempre ha sido un problema "oculto". A veces los ancianos no quieren reconocerse como víctimas de malos tratos por:

- ➔ temor a represalias
- ➔ confinamiento en instituciones
- ➔ negación

Por otra parte, los familiares o los cuidadores, no van a facilitar la detección por razones obvias. Tampoco ha habido mucha sensibilidad en este sentido por parte de profesionales sanitarios y recursos sociales para solucionar el problema, una vez detectado. Es un grupo escaso a pesar de ser un problema grave que afecta a un grupo de población que crece exponencialmente.

En la Primera Conferencia de Consenso sobre el anciano maltratado, celebrada en España en 1995, se **define maltrato al anciano** como: "Cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, practicado sobre personas de 65 y más años, que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la integridad física, psíquica, así como el principio de autonomía o el resto de los derechos fundamentales del individuo, constatable objetivamente o percibido subjetivamente".

5.6.1. FORMAS DE MALTRATO MÁS FRECUENTES

- Maltrato físico: Uso de la fuerza física. Agresiones con daño en la integridad corporal, con intención de provocar dolor, lesión corporal o ambas: golpes, quemaduras, fracturas, administración abusiva de fármacos o tóxicos.
- Maltrato psicológico: Cuando se inflige angustia, dolor emocional o estrés, a través de insultos y agresiones verbales, amenazas, intimidaciones, humillaciones, la infantilización, silencios ofensivos, amenazas de abandono o institucionalización, manipulación, chantajes, desprecio, violación de sus derechos impidiéndole tomar decisiones.
- Abuso social o violación de derechos: Son aquellas acciones que suponen el confinamiento o cualquier otra interferencia en la libertad personal del mayor. Por ejemplo, negación en la toma de decisiones; aislamiento social de amigos, nietos, etc., impedir el acceso a medios de comunicación etc. Algunas clasificaciones los consideran abusos psicológicos.
- Abuso económico: Mal uso o explotación del dinero, posesiones o bloqueo del acceso a dichos bienes. Impedir el uso y control de su dinero, chantaje económico.
- Abuso sexual: cualquier tipo de relación sexual no consentida empleando la fuerza, amenaza o aprovechándose del deterioro cognitivo del mayor o cuando la persona no es capaz de dar su consentimiento. En

algunas clasificaciones lo consideran como una especificidad de los abusos físicos.

- Negligencia
  - Física : No satisfacer las necesidades básicas: negación de alimentos, cuidados higiénicos, vivienda, seguridad y tratamientos médicos
  - Emocional: Consiste en la negación de afecto, desprecio, aislamiento, incomunicación.

5.6.2. CAUSAS DEL MALTRATO

Se han citado: el cambio de valores en nuestra sociedad actual en la que la juventud, la productividad, la salud son valores en alza, el anciano, enfermo con frecuencia dependiente e improductivo, es infravalorado y a veces resulta una "molestia" para familias nucleares con dificultades para cuidar al anciano. Sin duda los factores sociales y culturales están implicados, pero también otros, familiares e individuales.

Se han identificado factores asociados a maltrato, como el estrés del cuidador, problemas socio-económicos, antecedentes de violencia familiar etc., pero se consideran factores de riesgo mas que propiamente causales, ya que no siempre su existencia condiciona la aparición del problema, sino solo aumenta la probabilidad de que este aparezca.

5.6.3. CONSECUENCIAS DEL MALTRATO

- Lesiones físicas: lesiones por traumatismos, desnutrición, deshidratación, fracturas por caídas, úlceras por decúbito por negligencia, abandono o falta de cuidados, heridas por ataduras, abrasiones, quemaduras e intoxicaciones.
- Consecuencias psicológicas: Tristeza, trastornos emocionales, sufrimiento, depresión, ansiedad, ideación suicida, inhibición, somatizaciones y pseudodemencias.
- Sociales: aislamiento físico, psicológico o social.
- Se estima que los malos tratos tienen una importante repercusión en la utilización de servicios sanitarios; el aumento de la frecuentación, y de las hospitalizaciones condicionada por la morbilidad asociada a síntomas de la negligencia , el abandono o la violencia física.

5.6.4. FACTORES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE SER VÍCTIMA DE MALOS TRATOS

El mayor riesgo de recibir maltratos lo tiene una persona mayor incapacitada, dependiente, de edad muy avanzada y a cargo de un cuidador único desde hace tiempo, o bien de personal poco capacitado.

Perfil del mal cuidador

- Parentesco con la víctima.
- No acepta el papel de cuidador y no asume la responsabilidad que ello conlleva.
- Depende económicamente de la persona mayor, siendo habitual que la vivienda sea de la víctima.
- Consume fármacos, alcohol y/o drogas.
- Con antecedentes de enfermedad psiquiátrica o alteraciones de la personalidad.
- Tiene pobres contactos sociales.
- Renuncia a las ayudas médicas y de la comunidad.
- En las entrevistas suele ser hostil, irritable y suspicaz..
- Demuestra pérdida de control la situación.
- Historia previa de violencia familiar hacia su pareja y/o hijos.
- Sufre estrés por causas diversas, como pérdida de trabajo, enfermedad o problemas conyugales.

Factores de riesgo

- Edad avanzada.
- Deficiente estado de salud.
- Incontinencia.
- Deterioro cognitivo y alteraciones de conducta.
- Dependencia física y emocional del cuidador.
- Aislamiento social.
- Antecedentes de malos tratos.
- Sobrecarga física o emocional (situaciones de estrés, crisis vitales).
- Padecer trastornos psicopatológicos.
- Abuso de alcohol u otras toxicomanías.
- Experiencia familiar de maltrato a ancianos o violencia familiar previa.
- Incapacidad del cuidador para soportar emocionalmente los cuidados.
- Vivienda compartida.
- Malas relaciones entre la víctima y el agresor.
- Falta de apoyo familiar, social y financiero.
- Dependencia económica o de vivienda del anciano.

5.6.5. INDICADORES DE QUE EXISTEN MALOS TRATOS

Abuso físico: Las lesiones físicas son las más fáciles de detectar:

- Heridas
- Contusiones
- Lesiones en el aparato genital
- Fracturas, luxaciones y esguinces recurrentes
- Abrasiones o laceraciones en diferentes estadios

- Lesiones en la cabeza o en la cara (Fractura orbitaria, Alopecia errática por tirar de los pelos de forma agresiva y brusca)
- Quemaduras (En lugar poco frecuente, Producidas por objetos, Por líquidos muy calientes)
- Arañazos

Abuso psíquico:

- Alteraciones emocionales de la víctima (Depresión, Confusión, Ansiedad, Nerviosismo, Labilidad emocional)
- Actitudes instintivas de defensa del anciano
- Extrema cautela por parte del cuidador
- Amenazas de abandono y/o institucionalización
- Imposición de aislamiento físico y/o social
- Explicaciones confusas y diferentes del cuidador ante lesiones, considerando a la víctima no capacitada en su juicio
- Amenazas al anciano por parte del cuidador para controlar la situación

Negligencia física y abandono:

Los signos que traducen descuido, por un mal estado higiénico, también resultan obvios, sobre todo si se contrastan con el estado higiénico de quien acompaña al anciano.

- Deshidratación
- Desnutrición sin motivo aparente
- Anemia
- Mala higiene corporal
- Ropa inadecuada para el tiempo actual o sucia
- Caídas de repetición
- Impactación fecal
- Penetrante olor a orina o residuos fecales en los pliegues de flexión o el ombligo
- Gafas rotas o ausencia de las mismas cuando son necesarias
- Hipotermia, hipertermia
- Contracturas articulares por falta de movilidad
- Ulceras por presión en mal estado
- Ancianos que ingresan una y otra vez sin causa clínica que lo justifique
- Intoxicaciones por fármaco
- Incumplimiento terapéutico sistemático

Negligencia psicológica:

- Depresión
- Confusión, desorientación
- Ansiedad
- Pérdida de autoestima

- Llanto injustificado del mayor
- Mínimas conversaciones entre la víctima y el cuidador
- Actitud de indiferencia hacia el mayor por parte del responsable de los malos tratos
- El cuidador niega al mayor la posibilidad de relacionarse con otras personas
- Pérdida de la capacidad de toma de decisiones por parte de la persona mayor

Abuso patrimonial:

Una adecuada investigación social puede llevar a sospechar que se está manipulando el patrimonio del anciano; en ocasiones, esto no es tan fácil de detectar y es necesario adoptar medidas de carácter judicial.

5.6.6. SEÑALES DE ALERTA Y SIGNOS PRECOCES DE MALTRATO

- Las explicaciones del cuidador sobre las lesiones o de cómo ocurrió el incidente son contradictorias, poco coherentes o inverosímiles.
- Existe disparidad, contradicciones en el relato de lo sucedido entre paciente y maltratador.
- Retraso en solicitar la asistencia, se produce demora en la atención médica. Suele haber un intervalo prolongado de tiempo entre el trauma o la enfermedad y la visita al centro médico.
- Visitas reiteradas a servicios de urgencia y hospitales por motivos cambiantes.
- El mayor maltratado es llevado al hospital por otra persona distinta al cuidador.
- Administración involuntaria de medicamentos.
- Observamos en la monitorización de fármacos dosis inadecuadas infraterapeúticas, toxicidad o empleo de fármacos (psicotropos) no prescritos por el médico.
- Ausencia de respuesta ante tratamientos adecuados.
- Mala evolución de las lesiones (úlceras) tras aplicación de las medidas adecuadas.
- El mayor es abandonado en urgencias por exacerbación de enfermedades crónicas a pesar de un tratamiento correcto y recursos adecuados.
- Desnutrición sin motivo aparente.
- Deshidratación.
- Caídas reiteradas.
- Actitud de miedo, inquietud o pasividad.
- Estado emocional: alteración del estado de ánimo, depresión, ansiedad o confusión.
- Negativa del cuidador a dejar solo al anciano.

- Se detecta falta de comunicación de la víctima con el médico si el cuidador está presente.
- La vivienda presenta unas condiciones higiénicas pésimas y es inadecuada para vivir en ella.
- Existe una historia previa de episodios sospechosos de malos tratos

5.6.7. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PREVENCIÓN

- El maltrato es un fenómeno extremadamente complejo, multicausal y pluridimensional.
- No podemos aceptar que la violencia familiar es un asunto privado.
- El maltrato se puede producir en cualquier contexto social: desde el domicilio hasta la más lujosa residencia de mayores, independientemente del nivel cultural del perpetrador.
- La persona mayor maltratada recibe más de un tipo de maltrato y será maltratada más de una vez.
- Sin intervención, el maltrato casi siempre empeora. El maltrato raramente es un hecho aislado, la recurrencia se estima en un 80%. Sin intervención, también aumenta la mortalidad.
- Sólo se puede detectar una situación de maltrato si los que se enfrentan al hecho concreto tienen presente esa posibilidad.
- Todo ciudadano tiene la obligación ética y legal de notificar a las autoridades los caos de sospecha. Los profesionales de la sanidad y los trabajadores sociales tienen especial obligación de identificar y actuar en los casos con razonable sospecha de maltrato.
- Mientras exista un solo caso de un mayor maltratado, debe ponerse en marcha la estrategia correspondiente. El asunto es grave con independencia de su incidencia.

5.6.8. QUÉ HACER ANTE UN CASO DE SOSPECHA DE MALTRATO

- Creer en lo que nos dice la persona mayor.
- No culpabilizar nunca a la víctima.
- Investigar la verdad.
- Consultar a profesionales especializados.
- Demandar orientación a los equipos profesionales.
- Cumplir los procedimientos legales.
- Denunciar a los órganos judiciales para que asistan y protejan al mayor.
- Recurrir a los organismos de orientación y atención a los mayores víctimas de malos tratos.

5.6.9. CÓMO INTERVENIR ANTE UN CASO DE MALTRATO

- Tratamiento de las lesiones físicas y de aspectos psicológicos.
- Información al paciente.
- Parte de lesiones o denuncia al Ministerio Fiscal.

- Criterios de remisión a especialistas.
- Intervención del asistente social.
- Intervención de los servicios sociales.
- Estrategias de protección.
- Control de factores de riesgo.
- Apoyo al cuidador: para evitar la sobrecarga o la claudicación del cuidador.
- Tratamiento al cuidador cuando padece un trastorno psicopatológico abordable.
- Seguimiento del caso.

5.6.10. LAS CONCLUSIONES DE LA PRIMERA CONFERENCIA DE CONSENSO SOBRE EL ANCIANO MALTRATADO EN ESPAÑA

1) Desconocemos la prevalencia.
2) El maltrato no es privativo de clase social desfavorecida. Puede darse en la familia o en instituciones y los principales implicados son familiares y cuidadores.
3) El desconocimiento y la negación del problema dificultan prevenirlo e intervenir.
4) No existe legislación específica de protección de las personas ancianas frente a los abusos, pero se deben notificar los casos de sospecha.
5) Todo profesional en relación con el anciano debe estar alerta respecto a signos y síntomas de maltrato.
6) Los propios ancianos deben conocer el problema del maltrato y los recursos sociales existentes para evitar reincidencias o secuelas.
7) Determinados factores de riesgo aumentan la probabilidad de maltrato.
8)Se necesita realizar mayor esfuerzo en investigación sobre el maltrato al anciano.

5.7. LA APROXIMACIÓN A LA MUERTE. EL ENFERMO TERMINAL

5.7.1. DEFINICIÓN

Se utiliza este término para referirse a las enfermedades incurables para las que se carece de solución. Suelen implicar una corta esperanza de vida.

En la situación de enfermedad terminal concurren una serie de características que son importantes no sólo para definirla, sino también para establecer adecuadamente la terapéutica.

Los elementos fundamentales son:

- Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable.
- Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.

- Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes.
- Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte.
- Pronóstico de vida inferior a 6 meses.

El cáncer, sida, afecciones crónicas de los sistemas cardiovasculares (arterioesclerosis y miocardiopatías), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las cirrosis hepáticas cumplen estas características, en mayor o menor medida, en las etapas finales de la enfermedad. Clásicamente la atención del enfermo de cáncer en fase terminal ha constituido la razón de ser de los Cuidados Paliativos.

Los enfermos terminales requieren unos cuidados muy continuos para la sintomatología cambiante que no serán cuidados "intensivos" sino cuidados muy intensos, aplicados en un entorno multidisciplinar, bajo la filosofía de los Cuidados Paliativos, para conseguir que estos enfermos vivan con plenitud sus últimos meses o días y tengan una buena muerte.

Es fundamental no etiquetar de terminal a quien tiene potencialidad para curarse. Existe el término de enfermos pseudoterminales: son los enfermos que son catalogados de terminales sin cumplir todos los requisitos mencionados causando la ansiedad de enfermos terminales, lo que le repercute en su calidad de vida. Generalmente es debido a un fallo de afectación en la enfermedad de base y/o al cálculo del pronóstico de vida, también por adelantos de diagnóstico y/o pronósticos no confirmados.

También hay que diferenciar al enfermo terminal (que se halla en situación incurable, irreversible, manteniendo una calidad de vida y unas expectativas más o menos largas) del moribundo (enfermo cuyo desenlace se prevee cercano).

5.7.2. NECESIDADES DEL ENFERMO TERMINAL

El hombre es un ser único en el que conviven distintas realidades o niveles (físico, mental y emocional, relacional, y espiritual).

Estos niveles son dependientes los unos de los otros y un cambio en uno de ellos afectará, en mayor o menor medida, a los demás. Por lo tanto, cuando la persona evidencia problemas de funcionamiento a nivel físico, hay que tener en cuenta que estos problemas tendrán su correlato en los otros niveles.

En el caso de una persona con una enfermedad Terminal su deterioro físico es muy severo y esta problemática afecta a todas sus otras realidades (mental y emocional, relacional, espiritual).

Necesidades desde el punto de vista físico

- Hay que ofrecerle atención médica y de enfermería
- Atender la higiene:
  - Aseo Bucal
  - Baño diario
  - Limpieza de los ojos
  - Aseo de genitales
  - Acicalamiento (vestirse, peinado, rasurado)
  - Aseo de faneras (uñas)
- Realizar los cuidados de la Piel:
  - Mantener sábanas limpias y estiradas.
  - Baño de aseo diario sin soluciones y cada vez que sea necesario
  - Aplicar cremas corporales (grasas u oleosas) haciendo énfasis en las áreas de apoyo.
  - Dar masajes en las zonas de riesgo.
  - Detectar tempranamente la aparición de lesiones de úlcera por presión.
  - Evitar polvos de talco aplicados directamente sobre la piel.
  - Realizar cambios de posición cada una o dos horas.
  - Aumentar la hidratación oral.
  - Colocar rodillos en zonas de prominencias óseas.
  - No dar masajes sobre las zonas enrojecidas
- Cuidar la alimentación
  - Estimular y controlar la ingestión de los nutrientes necesarios diariamente.
  - Presentar de forma atractiva los alimentos al enfermo.
  - Recomendar ingestas en pequeñas cantidades pero de forma frecuente.
  - Conocer la técnica de alimentación parenteral (si necesario)
  - Administrar líquidos para evitar deshidratación y estreñimiento.
  - Estimular en todo momento el acto de la alimentación mediante conversaciones agradables.
- Aliviar el dolor:
  - Administrar el medicamento indicado para el alivio del dolor.
  - Observar reacciones adversas de las drogas administradas y control estricto de éstas.
  - Cambios frecuentes de posición que alivien el dolor.
  - Atender el patrón de eliminación del enfermo
  - Cuidar el sondaje vesical intermitente o permanente si necesario.
  - Observar características de la orina y cuantificar en cada turno.

  - Observar características de las heces fecales (sangramiento etc.).
  - Movilizar al enfermo si el estado físico lo permite.
  - Favorecer el confort y la seguridad física
- Favorecer ambiente adecuado:
  - Aislar al enfermo en casos necesarios, evitar ruidos, respetar horarios de descanso.
  - Protegerle de lesiones y caídas (fijaciones, eliminación de obstáculos...).

Necesidades desde el punto de vista psicológico

La OMS hace referencia a las necesidades psicológicas en los enfermos terminales:

NECESIDAD	COMENTARIO
Seguridad	Sentimiento de protección ante una amenaza
Pertenencia	Deseo de sentirse necesario y no suponer una carga para los demás
Amor	Necesidad de expresión de afecto y contacto humano
Entendimiento	Necesidad de comprender las explicaciones sobre los síntomas y sobre la naturaleza de la enfermedad
Aceptación	Necesidad de ser aceptado con independencia del estado de ánimo, la sociabilidad y la apariencia
Autoestima	Se favorece involucrando al enfermo en la toma de decisiones, especialmente en aquellas que se refieren a su dependencia física
Confianza	Necesidad de una comunicación honesta con la familia y los cuidadores. Seguridad de estar recibiendo el mejor cuidado posible.

- Hay que estar disponible para que el enfermo Terminal pueda expresar sus sentimientos estando seguro de que se le comprende.
- Pide tres cosas: "escuchadme, comprendedme, no me dejéis caer".
- Las visitas reducen la angustia.
- El trato debe ser cortés y afectuoso.
- Se debe alejar todo disimulo. Hay que ser sinceros y estar dispuestos a ofrecer explicaciones.
- Hay que tratar cualquier trastorno psicológico que se presente.

Necesidades desde el punto de vista sociológico

- Hay que responder a la necesidad de pertenencia permitiéndole:
  - despedirse de sus allegados
  - solventar cuentas pendientes

Necesidades desde el punto de vista espiritual

Hay que mostrarle factores de aliento para vivir serenamente el tiempo que le queda, como la fe en Dios y en su misericordia, las realizaciones de su vida, la seguridad de que se acordarán de él.

5.7.3. ENSEÑANZAS

- Las personas con Enfermedades Terminales se desenvuelven mejor cuando saben qué esperar a lo largo de su jornada. Además, les va mejor cuando no tienen que enfrentar su situación solos.
- La mayoría de las personas prefieren saber si sus seres queridos tienen Enfermedades Terminales porque así ellos pueden sacar mayor provecho del tiempo que les queda por delante.
- Los intentos de reconciliación son siempre esfuerzos que valen la pena, aún cuando no se logre el resultado esperado porque morir en paz es mucho mejor que vivir una vida llena de hostilidad.
- Las ET generalmente llevan a las personas a aislarse o a desarrollar un amor más profundo por quien padece la enfermedad. Amar es siempre la mejor opción en cualquier caso.
- Quienes padecen ET se sienten frecuentemente solitarios y necesitan saber que son amados. El contacto físico ayuda a reafirmar el amor que se siente por ellos.
- Cualesquiera que sean sus necesidades emocionales, las enfermedades terminales las enfatizarán, incluyendo depresión y pensamientos suicidas.
- El rango de emociones que frecuentemente vive un paciente con enfermedad terminal incluye: Humillación, Rabia, Culpa, Soledad, Temor, Ansiedad.
- Cuando no se sabe qué decir, el silencio es una opción muy valiosa. Muchos pacientes se sienten comprendidos y cómodos sólo por el hecho de contar con la presencia de otra persona. Espere que los pacientes hagan preguntas difíciles. Está bien si tiene que admitir que no tiene la respuesta. Considere que él quizás no necesite respuesta,
- sino más bien alguien quien lo escuche. Esté preparado para escuchar confesiones muy serias.
- Si desea ayudar a un paciente de alguna enfermedad terminal, acuda continuamente a él ofreciendo su ayuda. No espere que él o ella lo llame para pedirle ayuda.

5.7.4. DERECHOS DE LA PERSONA EN SITUACIÓN TERMINAL

- Ser tratado como un ser humano hasta el fin de su vida.
- Recibir una atención personalizada.
- Participar en las decisiones que afecten a los cuidados que se le han de aplicar.

- Que se le proporcionen los medios necesarios para combatir el dolor.
- Recibir una respuesta adecuada y honesta a sus preguntas, dándole toda la información que él pueda asumir e integrar.
- Mantener su jerarquía de valores y no ser discriminado por el hecho de que sus decisiones puedan ser distintas a las de quienes le atienden.
- Mantener y expresar su fe.
- Ser tratado por profesionales competentes, capacitados para la comunicación y que puedan ayudarle a enfrentarse con su muerte.
- Recibir el consuelo de la familia y amigos que desee le acompañen, a lo largo del proceso de su enfermedad y en el momento de la muerte.
- Morir en paz y con dignidad.

5.7.5. LA AGONÍA

En esta etapa pueden aparecer nuevas necesidades y causas de sufrimiento tanto para el enfermo como para la familia. Estas necesidades requieren un enfoque dirigido a potenciar el bienestar y el confort físico, emocional y espiritual; a fomentar la consecución de una muerte digna y en paz.

El sufrimiento ha sido definido por Chapman y Gavrin como «un complejo estado afectivo y cognitivo negativo, caracterizado por la sensación que tiene el individuo de sentirse amenazado en su integridad, por el sentimiento de impotencia para hacer frente a dicha amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontarla».

El encuentro con la dependencia terminal es una causa de sufrimiento tanto para el paciente como para sus familiares y para los profesionales que les atienden. La ayuda suministrada requiere la comprensión del fenómeno del sufrimiento y de los factores que contribuyen al mismo.

No resulta extraño que los familiares y profesionales vinculen los síntomas físicos al sufrimiento y, aunque la presencia de dichos síntomas suele ser un antecedente importante, no son la única fuente de sufrimiento. El fracaso en la valoración del sufrimiento puede ocasionar confusiones en la ayuda y el acompañamiento ofrecido.

Modelo triangular de sufrimiento

- Sufrimiento en el paciente: Los síntomas físicos (como el dolor), los síntomas psicológicos y el sufrimiento existencial (la desesperanza, el sinsentido, la decepción, el remordimiento, la ansiedad ante la muerte y la alteración de la identidad personal), el sufrimiento de los familiares y de los amigos, así como la percepción de ser una carga para sí mismo y para los demás.
- Sufrimiento en la familia. Los factores psicosociales, la tensión emocional, la incertidumbre, el sentimiento de impotencia, el miedo a la

muerte, la alteración de los roles y estilos de vida, la percepción de que los servicios son inadecuados, la pena y el pesar por el deterioro del enfermo (anticipación de la pérdida), la carga de los cuidadores (trabajo físico, carga emocional, cansancio), el esfuerzo económico que se debe realizar por los costes que genera el cuidado del enfermo, y los conflictos que pueden crearse en los cuidadores (entre el deseo de dar unos cuidados adecuados y a la vez el deseo de que se acelere la muerte).

- Sufrimiento en los profesionales: La exposición constante al sufrimiento y a la pérdida, la frustración, la impotencia y el sentimiento de fracaso, la excesiva presión laboral con la percepción de carencia de recursos (materiales, humanos, tiempo), las dificultades en la comunicación y en la relación con el enfermo y con sus familiares, las altas expectativas de éstos, etc. Todos ellos son factores que pueden contribuir al agotamiento y al burnout.

Algunas características de la Agonía

- Aumento de la sensación de cansancio, debilidad y somnolencia.
- Menor interés por levantarse de la cama o recibir visitas.
- Menor interés por lo que sucede a su alrededor.
- Mayor frecuencia de confusión, ocasionalmente acompañada de angustia y agitación

Cuidados en la Agonía

- Revisar la medicación y suspender toda la prescindible, asegurándose de la disponibilidad de la medicación que pueda ser necesaria.
- Mantener la observación para obtener el mejor control de síntomas posible.
- Explorar los temores y deseos del paciente, permitiéndole expresar su tristeza y ansiedad.
- Tranquilizarle respecto a los síntomas, asegurarle que se le ofrecerán todos los medios posibles para aliviar su malestar.
- Mostrarse receptivo respecto a las necesidades culturales y religiosas del paciente.

Estertores premortem

Los estertores del moribundo son un síntoma muy frecuente y específico en esta fase. Son ruidos producidos por movimientos oscilatorios de las secreciones de las vías respiratorias superiores durante la inspiración y espiración. Generalmente se producen sólo en pacientes obnubilados o tan debilitados que no pueden expectorar.

Los factores de riesgo asociados con más frecuencia a los estertores del moribundo son el cáncer de pulmón y cerebral, mientras que los estertores más refractarios al tratamiento se asocian más a patología cardiopulmonar (incluidos infección, edema pulmonar y aspiración).

Además de las medidas generales (posición semiprono para facilitar el drenaje postural, explicar el proceso fisiopatológico a los familiares, succión traqueal o nasofaríngea suave).

5.7.6.ACTOS SIMPLES QUE SE PUEDEN REALIZAR PARA ACOMPAÑAR AL ENFERMO TERMINAL

- NO ME RECHAZES: sé el amigo... el ser amado que siempre has sido.
- TÓCAME: un simple apretón de manos me hace saber que todavía te importo.
- LLÁMAME Y DIME QUE TRAES MI PLATO FAVORITO: si lo haces, tráelo en platos desechables para no preocuparme en devolverlos.
- LLORA CONMIGO: cuando yo lo haga, y también ríe conmigo. La enfermedad aísla. Ayúdame a seguir en contacto con otros.
- INVÍTAME A SALIR A PASEAR: sin olvidar mis limitaciones.
- LLAMA Y PREGUNTA SI DESEO ALGO EN ESPECIAL: y si puedes, tráelo.
- ANTES DE VISITARME, LLAMA A ANUNCIARTE: habrá momentos en que no pueda o no quiera recibir visitas, pero no permitas que eso haga que temas venir a verme; necesito tu compañía, no quiero sentirme solo.
- AYUDAME A CELEBRAR DIAS ESPECIALES: (y la vida en sí). Redecora mi cuarto en el hospital, hospicio o mi hogar, trae flores o algún detalle bello.
- AYUDA A MI FAMILIA: invítalos a salir. Yo estoy enfermo, pero ellos también sufren, ofrécete a venir y quedarte conmigo mientras los que me acompañan toman un descanso.
- SÉ CREATIVO: trae un libro de pensamientos, música especial, sigue tu corazón.
- HABLEMOS ACERCA DE LO QUE ME PASA: en ocasiones querré hablar de ello, no temas preguntar si lo deseo.
- ESCUCHA: cuando hablemos, quizá no necesite una opinión, tal vez sólo necesite desahogarme, ten la paciencia necesaria para escucharme y la sabiduría para no juzgarme.
- NO SIENTAS QUE SIEMPRE DEBES "HABLAR DE ALGO": tu presencia es más valiosa.
- NO MIENTAS ACERCA DE COMO ME VEO: sé que poco a poco mi cuerpo se deteriora, no llegues a extremos diciendo lo bien que luzco cada día, o como estoy de "acabado".
- POR FAVOR, INCLUYEME EN LA TOMA DE DECISIONES: voy perdiendo tantas cosas, por lo que no me niegues la posibilidad de sentir que aún soy útil e independiente en algo, por pequeño que sea.

- HÁBLAME EN FUTURO: mañana, el otro mes, el otro año, la esperanza es básica para mí.
- ACUDE A MI LADO CON UNA ACTITUD POSITIVA: ser realista no significa dejar de buscar algo bello detrás de cualquier circunstancia, por dura que sea.
- ¿QUÉ PASA EN LAS NOTICIAS?: el hecho de estar enfermo no me separa de mi entorno, mientras lo solicite, cuéntame que pasa en el mundo, con mi equipo favorito; no temas darme "malas noticias", ya recibí la más grande.
- SIMPLEMENTE MÁNDAME UNA POSTAL: si mi proceso es muy duro para ti y no te atreves a venir, busca la manera de hacerme saber que te importo.
- REZA POR MÍ: y comparte tus actos de fe conmigo.
- CUÉNTAME CÓMO TE GUSTARÍA AYUDARME: y si estoy de acuerdo, HAZLO.
- NO ESPERES A QUE MUERA para expresarme tu cariño o tu inconformidad con algún evento pasado, tus palabras también son actos de amor.
- DAME PERMISO DE MORIR: el verdadero amor no amarra, muero de mi enfermedad, no de mi amor hacia ti.
- CUANDO MUERA, acompaña a mi familia, ofréceles un abrazo y hazles saber cuánto los amo.